

Autonomi, Etik & Sygepleje

- En filosofisk analyse og diskussion om forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen

Speciale i filosofi af Jesper Jungløw Nielsen ved Aarhus Universitet

Navn: Jesper Jungløw Nielsen

Årskortnummer: 20051093

Vejleder: Jørgen Husted

Studieordning: Kandidat/2007

Antal sider: 74

Antal typeenheder (tegn og mellemrum): 175.824

Indholdsfortegnelse

Indledning	S.1
Metodeovervejelse	S.4
Begrebsdefinitioner	S.6
Det kantianske autonomibegreb	S.8
Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb	S.13
Fra moralsk til personlig autonomi	S.22
Selvbestemmelse og personlig autonomi – et konsekvensbetragende perspektiv	S.25
Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme	S.38
Om forholdet mellem autonomi og omsorg	S.40
Kritik af det ontologiske omsorgsideal	S.51
De Sygeplejeetiske Retningslinjer	
– Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis	S.54
Case analyse	S.57
Konklusion	S.65
Engelsk resumé / English resume	S.72
Litteraturliste	S.74

Indledning

Udgangspunktet for specialet er en filosofisk analyse og diskussion om forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen. Analysen og diskussionen vil vise, hvilke teoretiske redskaber en sygeplejerske skal have kendskab til for at kategorisere en patients evne til at besidde egenskaben autonomi. Heri ogs  evnen til at skelne mellem det autonome valg og den autonome person. S ledes forefindes to hovedpunkter i specialet; hvorn r kan sygeplejersken retf rdigvis klassificere patienten som autonom eller ikke-autonom, og hvorledes skal sygeplejersken forholde sig til forholdet mellem autonomi, pleje og behandling? Vi vil se, at sygeplejersken skal v re i stand til at fremme kvalitet af sine etiske overvejelser, s ledes at beslutningsgrundlaget for sygeplejerskens overvejelser sker p  et velbegrundet grundlag, hvori hun er etisk i stand til at argumentere for og imod hendes valg.

Indledningsvis pr senteres den tyske filosof Immanuel Kants autonomibegreb som grundfundamentet i sygeplejens etiske univers, det Kategoriske Imperativ. Imperativet fremst r som et moralsk ideal, hvori fornuftsv senet har agtelse for moralloven og pligten, heri respekten for medmennesket samt egen person. Via fornuften er den enkelte i stand til at agere som et frit selvlovgivende v sen; det vil sige, et menneske med egenskaben autonomi. Den kantianske pligtetik defineres s ledes som en moralsk autonomi, hvori fornuftsv senet, i denne optik sygeplejersken, tilsides tter egne interesser og  vrige tilb jeligheder for derimod at anerkende medmennesket, patienten, som et m l-i-sig-selv. Dermed sikres, at sygeplejersken, i kraft af det kantianske frihedsbegreb som foruds tter autonomi, kan erkende samt udf re moralsk v rdifulde og begrundede handlinger, hvis motiv er pligten.

I afsnittet *Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb* g res det kantianske autonomibegreb praksis anvendeligt. Dertil bruges filosofen Tom L. Beauchamps kantianske tilgang til autonomi. Ved at opstille et minimumskriterium for autonomi tilbydes sygeplejersken et redskab til at vurdere, hvorvidt en patient er i stand til at tr ffe autonome valg. Det skal noteres, at Beauchamps autonomibegreb begr nses i og med, at det udelukkende fokuserer p  det autonome valg og ikke det autonome

menneske. Dette betyder selvfølgelig ogs , at vi, i visse situationer, m  stille os kritiske over for Beauchamps teori, da denne, i forl ngelse af Kant, ikke besidder et bredt nok perspektiv i autonomiens henseende. Dette betyder, at det sn vre autonomibegreb, som Beauchamp pr senterer, ikke er bredt nok i sin anvendelse; det sikrer patienten fundamentale rettigheder, s som respekt for autonomi, men det udelader, via sin isolerende tilgang til hvert enkelt fornuftsv sen, flere facetter i definitionen af autonomi. I afsnittet *Fra moralsk til personlig autonomi* vises, hvorledes vi bliver n dt til at skelne mellem disse to autonomibegreber s ledes, at vi kan inddrage patientens egne v rdier i pleje- og behandlingsforl bet.

I belysningen af denne problematik inddrages i analysen en case omhandlende en lungecancerpatient. Vi vil se, at denne patient ikke besidder autonomi, og at vi derfor har brug for et redskab til at assistere hende til, p  sigt, at v re i stand til at (gen)besidde denne egenskab. Dette redskab finder vi hos Laura Waddell Ekstrom, som pr senterer en koh rent pr ference teori, som tilf jer autonomibegrebet et lag, som den kantianske optik ikke inddrager; et refleksivt lag, hvorved sygeplejersken, ved brug af dette redskab, kan vurdere samt forst  patientens definition af *det gode* og derved kan tilrettel gge en eventuel pleje og behandling herefter. Dette vil sige, at patientens v rdi og karaktersystem inddrages i kraft af dennes integrerede selv. Med tilf jelsen af dette ekstra lag, bliver autonomiens grundlag derved ogs  til en bredere kompleks teori, hvorved flere facetter n dvendigvis m  inddrages. Derved bliver begrebet autonomi til en facet af begrebet selvbestemmelse; en patient skal v re i stand til at besidde facetterne selvudvikling, selvstyre og selvansvar samt autonomi for at besidde evnen selvbestemmelse. Dette vil sige at v re i stand til at besidde magt over egen tilv relse. Er patienten ikke i stand til dette, skal sygeplejersken medvirke til, at dennes selvbestemmelses evne, s  vidt muligt, fremmes, s ledes at patienten vil v re i stand til at tr ffe st rre valg, som har indflydelse p  dennes livsforl b, og derved vil v re i stand til at etablere et koh rent pr ference system, som stemmer overens med vedkommendes integrerede selv.

I tilf lde af at patienten rent faktisk lever op til de krav, som selvbestemmelses begrebet indbefatter, kan sygeplejersken ikke retf rdigg re at g  imod patientens  nsker,

da dette vil v re en kr nkelse af patientens autonomi og derved ogs  v rdighed og integritet. S danne tilf lde belyses og diskuteres i afsnittet *Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme*, hvor en patient - psykoanalytikeren Sigmund Freud - begrunder, hvorfor han ikke vil indtage den professionelles anbefalede medicin. Forskellen p  Freud og lungecancerpatienten er, at Freud netop er i stand til at begrunde sit valg, mens lungecancerpatienten ikke kan. Derved m  sygeplejersken acceptere Freuds valg, mens tilf ldet med lungecancerpatienten g r, at sygeplejersken m  fors ge at bidrage til, at patienten kan besidde en st rre grad af selvbestemmelse og derved, p  sigt, v re i stand til at begrunde sit valg. Inden dette er tilf ldet, kan vi ikke tale om et  nske, som n dvendigvis skal respekteres.

Ekstrom repr senterer en konsekvensbetragtende etik, hvorved det netop er tilf ldet, at sygeplejersken m  vurdere, hvilke konsekvenser ville v re bedst for patienten i henhold til et specifikt pr ference system, og hvorvidt sygeplejersken kan bidrage til, at patientens pleje og behandling inddrager disse, s ledes at patienten kan bevare sin v rdighed.

Problematikken ved henholdsvis pligtetik og konsekvensbetragtende etik er, at de som s danne ikke indbefatter patienten p  et medmenneskeligt plan. Disse to etikker er ikke i stand til at ud ve omsorg, som er en af sygeplejeetikens grundl ggende v rdier. Dette medmenneskelige perspektiv inddrages i afsnittet *Om forholdet mellem autonomi og omsorg*, hvor teologen Knud Ejler L gstrups etiske fordring bidrager med et perspektiv om medmenneskelighed, som de to  vrige teorier ikke kan inddrage. Dog m  vi n dvendigvis ogs  forholde os kritisk til omsorgsidealet i sygeplejen, hvilket diskuteres i afsnittet *Kritik af det ontologiske omsorgsideal*, hvori der argumenteres for, at vi m  have objektive rammer for, hvorledes en patient skal behandles, s ledes at vi i plejen ikke blot antager, hvad der er den korrekte pleje og behandling for patienten, men rent faktisk har et teoretisk grundlag for at vurdere og begrunde den specifikke pleje og behandling.

I afsnittet *De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis*, anskuer vi forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje i et

praksisorienteret perspektiv. På baggrund af de tre teorier, vi har analyseret og diskuteret, anvender vi den Professionsetiske Beslutningsmodel og de principper, som omhandler sygeplejerskernes praksisstandarder samt mål og værdier til at give en praksisredskab for, hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til et specifikt etisk dilemma. Derefter følger afsnittet *Case analyse*, hvorved vi vil se, hvorledes sygeplejersken skal være i stand til at løse et etisk dilemma med de redskaber, vi har stillet til rådighed; pligt, konsekvensbetragtelse og omsorg.

Vi vil i dette se, at sygeplejersken aldrig udelukkende må tænke i etiske endimensionelle ideologiske baner; man skal nødvendigvis vurdere, hvilke valg er bedst for en mulig løsning af et etisk dilemma ved at anskue dilemmaet ud fra alle tre etiske positioner, hvilket afslutningsvis præsenteres i specialets konklusion.

Metodeovervejelse

Specialet udspringer af et ønske om at belyse de forhold, som spiller ind i forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje.

Indledningsvis vil jeg nævne, at jeg i foråret 2012 havde fornøjelsen af at medundervise i etik på Sygeplejerskeuddannelsen på VIA University College, Aarhus i samarbejde med Adjunkt, sygeplejerske, cand.mag. Thea Qvist Hjørnholm. Forløbet gav et indblik i, hvordan de sygeplejestuderende arbejder med etiske dilemmaer og problematikker. Dette har været særdeles brugbart i udarbejdelse af specialets praksisorientering, da jeg derved fik indblik, i hvilke ressourcer sygeplejersken har stillet til rådighed rent fagligt. Men i forlængelse af dette gik det op for mig, at de studerende ofte var meget endimensionelle i deres etiske tilgang; de henholdte sig forbløffende meget til begrebet omsorg og Kari Martinsens indlæsning af Knud Ejler Løgstrup i sygeplejen. Til tider forekom det, at de var villige til at tilsidesætte den enkelte patients autonomi for til gengæld at udøve en nærmest anmassende grad af omsorg. Deraf blev jeg gjort opmærksom på de studerendes manglende filosofiske redskaber til at analysere og kategorisere en patient som autonom og selvbestemmende. Specialet har således til formål at opstille sådanne redskaber,

således at sygeplejersken, i praksis, vil være i stand til at anvende disse redskaber samt begrunde dem i teoretisk.

Specialets metodiske tilgang er hermeneutisk; gennem en spørgen til forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje kan vi komme frem til en grundlæggende forståelse for dette forhold, samt hvilke redskaber vi skal bruge til at løse de eventuelle etiske dilemmaer, som kan opstå, når autonomi, etik og sygepleje betragtes og anskues i samme sfære. Tesen lyder; det enkelte autonome menneske må nødvendigvis være et mål-i-sig-selv, hvis ønsker og præferencer sygeplejersken ubetinget må respektere, så længe at patienten ikke skader andre. Men besidder patienten ikke autonomi, er der grundlag for professionel indgriben, således at et onde, eller flere, afværges. Tilgangen til at analysere dette forhold tager udgangspunkt i den kantianske tradition, hvori mennesket, fornuftsvæsenet, altid er mål-i-sig-selv. Fremgangsmåden heraf er, i kantiansk optik, en teoretisk analyse af, hvorledes mennesket kan være i stand til at besidde egenskaben autonomi. Denne besiddelse er grundlæggende for vores forståelse af mennesket, som et væsen, hvis autonomi vi aldrig må krænke. Via Kants teoretiske tilgang til autonomi kan vi give et grundlag for det ukrænkelige autonome menneske. Men vi vil se, at jo mere vi praksisgør etik i sygeplejen, jo større bliver risikoen for krænkelse af den enkelte. Derfor har sygeplejersken brug for nogle redskaber til at vurdere, hvorvidt den enkelte patient er autonom, og i stand til at besidde magt over egen tilværelse.

Således er der en klar rød tråd mellem den kantianske pligtetik, som danner det etiske grundlag i sygeplejen til en konsekvensbetragende etik, hvorved man har redskaber til at hjælpe patienten til at udøve selvbestemmelse. En sidste tradition, som vi må inddrage, funderes på sygeplejerskens idealkarakter og evne til at betragte og forstå patienten på et medmenneskeligt plan, således at sygeplejersken er i stand til at udøve pleje, hvis incitament er omsorg.

Jeg har valgt at bruge Immanuel Kant som grundstenen for min analyse af autonomi, etik og sygepleje, fordi Kants teoretiske argumenter giver mulighed for, at vi ubetinget kan klassificere det autonome menneske som et mål-i-sig-selv. Jeg har valgt at bruge værket *Grundlæggelse af sædernes metafysik [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten]*

(1785), fordi v rkets deontologi, heraf begrebet pligtetik, via filosofisk teori, er grundlaget for moralsk autonomi. Og det er dette autonomibegreb, som er specialets grundlag. Uden dette begreb kan vi ikke tale om personlig autonomi eller et medmenneskeligt ontologisk ansvar. Dette betyder selvf lgelig ikke, at der ikke vil forekomme kritik af Kants moralske autonomi, tv rtemod, men vi skal altid have in mente, at moralsk autonomi er f rsteinstans for besiddelse af personlig autonomi, det vil sige selvbestemmelse.

Specialet vil metodisk bev ge sig fra teori til praksis. I dette vil vi se, hvorledes sygeplejerskens valg i den specifikke situation har behov for en teoretisk opbakning, s ledes at denne kan begrunde sit valg i et givet etisk dilemma. Sygeplejersken m  derved inddrage de tre pr senterede teorier i specialet samt de Sygeplejeetiske Retningslinjer og vurdere, hvilke principper som hun skal g re brug af for at l se dilemmaet.

Begrebsdefinitioner

Jeg vil i det f lgende pr sentere en r kke af de begreber, som anvendes i specialet, som giver l ser en foruds tning for at forst  samt bevare overblikket over begreberne, og hvorledes disse anvendes.

Det grundl ggende begreb er *autonomi*. Begrebet betegnes som det sn vre autonomibegreb. Begrebet er en sammens tning af de oldgr ske ord 'autos' (selv) og 'nomos' (lov); at handle autonomt betyder at v re i stand til at ud ve selvlovgivning. Specialet anvender begrebet i kantiansk forstand; tanken om moralsk autonomi, hvorved det autonome menneske, fornuftsv snet, selv erkender og fasts tter loven for sin handling. Det er en lov, som erkendes via det indre, fornuften, men skal samtidig forst s som objektiv og kategorisk. Dette skyldes, at det er en gyldig almen lov – et kategorisk imperativ. Moralsk autonomi indeholder fordringen om respekten for medmenneskets autonomi, samt sin egen, i kraft af menneskets egenskab til at t nke og handle selv. I praksisanvendeligheden af begrebet opstilles et minimumskriterium for besiddelse af

autonomi som egenskab; *intention, forst else og fri af kontrollerende indflydelse*¹.

Besidder den enkelte disse, betyder det, at vedkommende besidder evnen til at træffe autonome valg. Dette er dog ikke ens betydning med, at der er tale om en autonom person. Heraf forskellen p  det autonome valg og den autonome person.

Begrebet personlig autonomi anvendes i specialet som et bredt og komplekst autonomibegreb. Dette begreb videref res til Laura Ekstroms koh rente pr ference system, hvorved den enkelte skal v re i stand til at give refleksiv begrundelse for sine valg og v rdier. Disse v rdier skal stemme overens med vedkommendes integrerede selv; det vil sige autoriserede pr ferencer, som st r i tr d med pr ferencer og  nsker. Det integrerede selv er s ledes et netv rk, som st tter hinanden. Processen heraf er l ngere sigtet og inkluderer livsanskuelser og v rdier. Derved kategoriseres personlig autonomi omhandlende personer og ikke blot valg. I denne proces forefindes det faktum, at den enkelte skal v re i stand til at ud ve selvbestemmelse og dertilh rende facetter. In mente skal det bem rkes, at autonomi ikke er altoverskyggende i dette begreb, men er  n blandt fire facetter, som skal besiddes, for at den ber rte kan ud ve selvbestemmelse; *selvansvarlighed, selvstyre, selvudvikling samt autonomi*.

Begrebet ontologisk omsorgsideal funderes p  L gstrups f enomenologiske tilgang til etikken, og hvorledes den enkelte sygeplejerske er i stand til at praktisere samt realisere sit professionelle og medmenneskelige ansvar. Dette skal forst s som en gylden middelvej, hvorved sygeplejersken ikke m  vige for meget til  n af de to modpoler, da dette ville betyde, at sygeplejersken ikke praktiserer sin profession i tilfredsstillende grad.

N r begrebet paternalisme anvendes, tages der udgangspunkt, hvis ikke andet er n vnt, i *svag paternalisme*. Det vil sige afv rgelse af et onde.

¹ Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Side 315

Det kantianske autonomibegreb

I v erket *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* (1785) bearbejder den tyske filosof Immanuel Kant fundamentet for pligtetikken, hvis fordring bygges p  indre pligter. De etiske og moralske valg, mennesket foretager, funderes p  noget, som er uafh ngig af de empiriske tilb jeligheder. Vi skal ikke forst  Kants metafysik som af den klassiske ontologiske karakter, men som det  verste princip for al moralitet, hvis beskaffenhed er af absolut karakter; et Kategoriske Imperativ².

De moralske principper, som fornuftsv snet foretager, er funderet p  den rene t nkning. Dette vil sige, at, i fornuftsv snet findes, a priori, et moralsk udspring, alts  en kilde, hvorfra moralloven p virker det fornuftige menneske til at foretage moralske v rdifulde valg. Qua egenskaben autonomi er vi i stand til at foretage valg og beslutninger, som bygger p  vilje og overvejelse. I adlydelse af moralloven er fornuften en n dvendighed for at tr ffe valget. Moralen er uafh ngig af vore  nsker og behov. Dette betyder, at moralen ikke finder sin v rdi i konsekvensen af handlingen, da handlingen kun har v rdi i kraft af, at den udf res af pligt. Det vil sige, at i valget m  vi skelne mellem viljen og tilb jelighed; viljen er s -at-sige midt imellem de moralske a priori principper og formalier, som forefindes i henhold til moralloven og de materielle a posterioriske principper, som forefindes i den ydre situations tilb jeligheder. For at undg  at tilb jeligheder kan forsvares som moralsk og etisk v rdifulde, indf rer Kant pligtbegrebet. Det kan godt t nkes, at et valg, eller en handling, tr ffes enten af fornuften eller tilb jeligheden, og at disse to poler tilf ldigt stemmer overens, men dette er ikke afg rende for, om valget er moralsk v rdifuldt eller ej; for ingen tilb jeligheder eller menneskelig beg r efter egeninteresse, og dette er uanset, hvor medmenneskelig denne er, og uanset om konsekvenserne er berigende for det st rst mulige antal v sner, s  kan dette ikke g re en handling moralsk v rdifuld. Hertil er det fornuftens afg rende rolle at vurdere formen af det princip, som styrer handlingen³. Fornuften handler s ledes efter en almen gyldig handlings lov, som Kant udtrykker p  f lgende m de; "[jeg skal aldrig handle anderledes, end] *at jeg ogs  ville, at min maksime skal blive en almen gyldig lov*⁴." Dette

² Kant, Immanuel; fra Indledning til *Grundl ggelse af s dernes metafysik* af Tom B geskov. Side 23

³ Politikkens filosofi leksikon. Side 232

⁴ Kant, Immanuel; *Grundl ggelse af s dernes metafysik*. Side 51

kategoriske imperativ betyder, at den moralske handling, som fornuftsv senet foretager, m  g lde som universal karakter, og derved kan man ikke handle moralsk v rdifuldt, hvis man udelukkende funderer handlingen p  egen interesse og nytte. Imperativet er et moralsk ideal, hvis gyldne regel, og pligt, er respekt for medmennesket og respekt for egen person.

I respekten for sig selv og medmennesket er fornuftsv senet i stand til at agere som et frit og autonomt v sen i og med, at det er sit eget lovgivende v sen. Det vil sige, at det besidder egenskaben autonomi. Men hvis fornuftsv senet er selvlovgivende, hvorfor skal det s  partout f lge pligten og loven og ikke bare sine egne tilb jeligheder, hvis det er det, som lystes, ogs  endda selv om disse lyster og behov er til gavn for dets medmennesker? Problematikken ved dette er if lge Kant, at der mangler s deligt indhold i gerningen; *"...for handlingens maksime mangler det s delige indhold, nemlig at der handles af pligt, og ikke af tilb jelighed"*⁵. Dette betyder, at tilb jelige handlinger, p  trods af menneskeligvenlige indhold, ikke besidder s delige indhold i kraft af en agtelse for pligten, og derved kan handlingen i henhold til pligtetikken ikke indeholde moralskv rdi men blot tilb jelighed. Til geng ld kan en person, hvis karakter af natur er lunefuld og ustadig, alligevel optr de h derligt p  grund af sin agtelse for pligten moralloven, da vi kan tale om en handling, hvis karakteregenskab betragtes moralsk v rdifuld, netop fordi moralen er af h jeste v rdi i og med, at valget ikke foretages ud fra tilf eldige tilb jeligheder, men g res ubetinget i henhold til pligten.

S ledes bliver fornuftsv senet en del af Kants ideale *form lenes rige*. Det bliver en del af dette i kraft af, at det er i stand til at agere som et frit autonomt v sen;

"heraf f lger det ubestrideligt, at ethvert fornuftsv sen som m l i sig selv med hensyn til alle love, som det m tte v re underlagt, tillige m  kunne anses for at v re alment lovgivende, idet det netop er dets maksimers egnethed til almengyldig lovgivning, der udm rker det som form l i sig selv; og det f lges ligeledes, at dets v rdighed (eller pr rogativ) frem for alle blotte naturv sner indeb rer, at det altid m  v lge sine

⁵ Kant, Immanuel; *Grundl ggelse af s dernes metafysik*. Side 46

maksimer ud fra opfattelsen af sig selv og alle andre fornuftsv esner som lovgivende v esner (der derfor kaldes personer). P   denne m  de er en verden af fornuftsv esner (mundus intelligibilis) muligt som et form  lenes rige, og det netop i kraft af alle personers egen lovgivning som medlemmer heraf⁶.

Dette betyder, at pligten i-sig-selv m   v  re et tilstr  kkeligt motiv for fornuftv esnet, n  r handlinger og valg skal udf  res. Fornuftsv esnet er ubetinget m  l-i-sig-selv. Dette m   selvf  lgelig ogs   g  lde patienten p   sygehuset, som skal modtage pleje. Patienten m   aldrig bruges som et middel til sygeplejerskens m  l, da dette ikke er i tr  d med patienten som m  l-i-sig-selv. Ej heller kan dette stemme overens med tanken om *form  lenes rige*, da s  dan en handling vil tilsides  tte den anden persons lovgivning. Lad os i forl  ngelse af dette se n  rmere p   forholdet mellem menneskets v  rdighed og agtelsen for moralloven. Som n  vnt m   pligten i-sig-selv v  re tilstr  kkeligt, og den er derfor ogs   en handlingsn  dvendighed i agtelsen for loven; agter vi loven, kan vi ikke handle anderledes, da alt andet vil v  re en handling uden moralsk v  rdi. S  ledes er det eneste, som loven dikterer, det f  rn  vnte Kategoriske Imperativ, som er den handlingsregel, som er g  ldende for alle fornuftsv esner.

At have agtelse for moralloven er at have pligt for det Kategoriske Imperativ; f  lger vi udsagnet, kan vi rationelt erkende pligten i en given situation; grundl  ggende m   fornuften fort  lle os, hvis den givne handling ikke kan g  lde som en almen lov, m   vi forkaste den. Kan handlingen til geng  ld g  lde som s  danne, m   denne n  dvendigvis v  re af v  rdifuld moralsk karakter og derved gyldig almen lov, Deraf m   vi f  lge denne handling, da den er fordret gennem agtelse for moralloven. At handle efter moralloven er derved grundlaget for at v  re sin egen lovgiver; dette m   grunde i et objektiv princip, som fornuften uafh  ngigt af tilb  jelighed erkender; *"Handl som om maksimen for din handling gennem din villen skulle blive en almengyldig naturlov"*⁷. Denne objektivitet er tvingende for viljen; det vil sige, at fornuften tvinger viljen til det objektive, hvilket er den iboende grund til, at det eksempelvis aldrig kan v  re tilladt at beg   sig en handling, som

⁶ Kant, Immanuel; *Grundl  ggelse af s  dernes metafysik*. Side 100-01

⁷ Kant, Immanuel; *Grundl  ggelse af s  dernes metafysik*. Side 78

bygger p  l gn samtidig med betyder dette udsagn, at moralloven er udtryk for fornuftsv snets v rdighed og v rdi samt et grundlag for n dvendigheden at opretholde dette, da v snet altid er form l i-sig-selv og ikke blot et middel. Deraf kan vi bev ge os mod endnu en formulering af imperativet; *"Handl s ledes, at du altid tillige behandler menneskeheden, s vel i din egen person som i enhver anden person, som m l, aldrig blot som middel"*.⁸ Princippet er et ubetinget kategorisk imperativ. I dette ytrer moralloven, at ethvert fornuftsv sen er v rdifuldt i-sig-selv, uafh ngig af alt andet, inklusiv konsekvenserne. I sygeplejen betyder dette, at pligten fordrer, at alle, uanset k n, alder, h jde, v gt osv., skal modtage lige behandling. At handle anderledes vil i-sig-selv ikke v re nogen handling af moralskv rdi, og deraf vil en handling af eksempelvis egeninteresse aldrig opfylde pligtens fordring da dette ikke vil v re i henhold til pligtens imperativ.

Kants pligtetik er grundlaget for den moralske autonomi, hvori fornuftsv snet er i stand til at tilsides tte egne subjektive interesser for til geng ld at v re i stand til at anerkende dets medmennesker som selvlovgivende autonome v sner, som besidder v rdi-i-sig-selv. Netop det, at patienten er et m l-i-sig-selv, er i sygeplejen et vigtigt fundament; det foruds tter, at b de sygeplejerske og patient er i stand til at st  til ansvar for egne handlinger og valg; i kraft af frihedsbegrebet kan vi via pligten erkende den moralskv rdifulde handling frem for en handling uden v rdi. Dette betyder s ledes, at b de sygeplejerske og patient n dvendigvis m  respektere den anden som et m l-i-sig-selv og aldrig blot som middel. Sygeplejersken kan ikke bruge patienten i egeninteresse og vice versa, da s dan handling vil v re uden moralsk v rdi, da den anden ikke respekteres som et m l, men blot v re blevet reduceret til et redskab, hvori den anden fors ger at opn  den egeninteresse, som fors ges opn et. S danne tilf lde lever un gtelig ikke op til imperativet, som fordrer den enkelte som m l-i-sig-selv samtidig med, at pligten ikke er motivet for s danne handling; deraf bliver v rdikarakteren forkastet, og maksimen kan n dvendigvis ikke g lde som en gyldig almen lov. Derved m  sygeplejersken af n dvendighed rette sig efter den a priori morallov, som er uafh ngig af al erfaring; moralloven er det grundlag, hvorp  sygeplejersken kan finde et absolut

⁸ Kant, Immanuel; *Grundl ggelse af s dernes metafysik*. Side 88

vejledningsgrundlag i sin handling. Dette betyder, at sygeplejersken, af pligt, n dvendigvis m  tilsides tte egne subjektive interesser, som drives af naturlige tilb jeligheder. I situationen er vedkommende i stand til, via viljen, at formulere et klart defineret valg, deraf handling. Moralloven er den uerfarende genstand, som g r det muligt, for at sygeplejersken kan frig re sig fra sine naturlige tilb jeligheder, grundet agtelse for moralloven. Og f lger sygeplejersken loven, s  er handlingen af princip  n v rdifuld moralsk handling. S ledes er fornuftsv snet af intrinsisk v rdi, og da loven er almen gyldig, g lder dette princip ogs  patienten; sygeplejersken kan derfor aldrig, hvis patienten er autonom, udf re og underkaste patienten paternalisme og derved sikre pligtetikken, at patienten bevarer sin autonomi, samt v rdighed.

Grundlaget for Kant er et rationalistisk og humanistisk syn, som p byder, at man altid skal respektere den anden som et m l-i-sig-selv, og derved skal man respektere dertilh rende autonomi. Derved er det i sygeplejen altafg rende, at viljen er selvlovgivende og autonom, uafh ngig af genstande – er dette tilf eldet s  m  udfaldet ubestrideligt v re det Kategoriske Imperativ. Hvis sygeplejersken eksempelvis lyver over for patienten, s  er dette i modstrid med moralloven, og derved er den l gnfulde ytring ikke af moralsk v rdi. S ledes har sygeplejersken ikke anvendt sin n dvendige fornuft, og derved kan hun ikke erkende imperativet.

Derved kan vi konkludere, at moralloven er en fordring om at sikre fornuftsv snets v rdi. Samtidig er det kantianske fornuftsv sen af intrinsisk v rdi, da det er i stand til at agere som selvlovgivende karakter, hvis valg er af moralsk v rdighed, da disse funderes p  agtelse for moralloven. Det er uafh ngigt af tilb jeligheder og konsekvenser, dvs. det altid er m l-i-sig-selv aldrig et middel. Netop dette er for etik i sygeplejen et vigtigt fundament; man kan ikke p f re det autonome fornuftsv sen paternalistisk tvang, da dette ville v re en kr nkelse af dets v rdighed og implicitte autonomi. I behandlings- og plejehenseende m  sygeplejersken altid anerkende patienten som en del af det kantianske *form lenes rige*, hvori b de patient og sygeplejerske er forenet ved f lleslov, hvor begge parter altid er m l-i-sig-selv. I praksis er dette en n dvendighed, s ledes at alle mennesker behandles lige.

Sp rsgsm let er s , hvorn r et fornuftsv esen i praksis er autonomt? Kant giver et teoretisk grundlag for, hvorn r vi er selvlovgivende v esner, hvis gerninger og handlinger er af moralsk v erdi, og hvorn r de ikke er. Men n r man som sygeplejerske st r i en situation, hvori man skal vurdere, hvorvidt patienten er autonom eller ej, s  lader den rene kantianske t nkning ikke v re en umiddelbar anvendt indikator for, hvorn r patienten kan vurderes som autonom eller ej. Dette er teorien ganske enkelt for kompliceret til. Vi m  derfor bev ge os fra den teoretiske Kant til  n mere specifik anvendt kantiansk etik, som kan give os svaret p , hvorn r en patient kan betragtes som autonom, og hvorn r patienten ikke kan.

Kant i praksis – om anvendelse af det kantianske autonomibegreb

At respektere en patients autonomi er at give plads til patienten som et selvlovgivende subjekt. Giver sygeplejersken ikke plads til, at patienten kan foretage valg grundet i egne v erdier og livsanskuelser, kr nkes patienten, da denne, som alle andre fornuftsv esner, er uerstattelig. Men det er ikke altid tilf eldet, at patienten rent faktisk lever op til Kants ideal om autonomi. Sp rsgsm let er s ledes, hvorn r og hvordan vi kan vurdere, hvorvidt en patient foretager autonome valg eller ej? At foretage s danne vurderinger er vigtigt for sygeplejersken, hvis hun skal leve op til fordringen om at behandle sit medmenneske med respekt og v erdighed; foretager sygeplejersken et forkert sk n, det vil sige, vurderer hun, at patienten ikke handler autonomt uvidende om, at vedkommende rent faktisk handler s ledes, s  kr nker sygeplejersken det uerstattelige m l-i-sig-selv ved at underl gge det tvang, og derved lider patientens autonomi alvorlig kr nkelse.

Det er sygeplejerskens pligt, *i sit arbejde at anvende fagligt sk n, kritisk stillingstagen mod og omtanke*⁹ samt *arbejde for at patienten bevarer sin v erdighed og integritet*¹⁰. S ledes skal sygeplejersken handle i henhold til professionen og til patienten. Derved har sygeplejersken et ansvar for at udvise professionalisme i sine sk n samt s rge for, at patienten bevarer sin v erdighed – ogs  p  trods af at der er tale om en patient, som ikke

⁹ Sygeplejeetisk r d 2010.  1.3

¹⁰ Sygeplejeetisk r d 2010.  2.4

l ngere besidder, eller m ske aldrig har haft, egenskaben autonomi. Jeg vil i det f lgende give et svar p , hvordan sygeplejersken kan anvende det kantianske autonomibegreb i praksis, s ledes at hun er i stand til at vurdere, hvorn r en patient handler autonomt, og hvorn r vedkommende ikke g r, og derved skal autonomien ikke respekteres, da egenskaben ikke er til stede.

En sygeplejerske, som arbejder med sindslidende personer, er ofte udsat for, at patienterne udviser anormal adf rd; i behandlings- og plejeprocessen er det sygeplejerens opgave at pleje og forebygge de lidelser, som patienten er udsat for. Da s danne patienter til tider kan forekomme at v re personer, som foretager autonome valg, kan det v re sv rt at skelne, hvorn r et valg rent faktisk er autonomt, og hvorn r det ikke er. En psykisk syg kan virke rationel i sine ytringer; vedkommende kan udtrykke pr ferencer, v rdier, livsanskuelser osv. Det vil v re forkert at kategorisere den sindslidendes valg som altid ikke-autonomt; ytrer patienten, at han gerne vil have et bestemt slags aftenm ltid frem for et andet, og grundlaget dertil er rationelt, s  kan sygeplejersken ikke blankt afvise dette  nske, da det umiddelbart lyder som et begrundet  nske. S dan patient, p  trods af at vedkommende er indlagt grundet psykisk ustabilitet, kan i givende situationer foretage autonome valg – derved ikke sagt at patienten er en autonom person. Det er i situationer som disse, at det er vanskeligt for sygeplejersken at vurdere, hvorn r patienten ytrer et autonomt valg, og hvorn r denne ikke g r. Dertil m  sygeplejersken give et professionelt sk n samtidig med, at patienten bliver behandlet med respekt. S ledes m  sygeplejersken vurdere, hvorvidt patientens valg er foretaget p  autonomiens minimumskriterium; *intention, forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse*¹¹. Disse kriterier er det fundament, som Tom L. Beauchamp angiver som grundlaget for det autonome valg. N r en sygeplejerske vurderer, om patientens valg er autonomt eller ej, kan minimumskriteriet anvendes som en kalk le, hvori sygeplejersken kan tr ffe et professionelt sk n; patientens valg skal respekteres, hvis og kun hvis, at der er tale om et autonomt valg – er tilf eldet, at valget ikke lever op til minimumskriteriumet, s  skal patientens autonomi ikke respekteres, men han skal stadig behandles med respekt

¹¹ Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Side 315

og v rdighed. Der er fra sygeplejerskens side s ledes tale om et kompetent sk n af, hvorvidt patienten er i stand til at ud ve autonomi; s ledes m  sygeplejersken vurdere, hvorvidt patientens valg er autonomt eller ej. S ledes bliver minimumskriterierne *intention, forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse* grundlaget for, hvorn r patienten ikke kan v re i stand til at indg  eksempelvis et informeret samtykke. Er patienten ikke i stand til at handle autonomt, vil det indg  i et til flere af f lgende udsagn:

- 1) *Inability to evidence a preference or choice*
- 2) *Inability to understand one 's situation or relevant similar situations*
- 3) *Inability to understand disclosed information*
- 4) *Inability to give a reason*
- 5) *Inability to give a rational reason (although some supporting reasons may be given)*
- 6) *Inability to give risk/benefit related reasons (although some rational supporting reasons may be given)*
- 7) *Inability to reach a reasonable decision (as judged, e.g., by a reasonable person standard)¹²*

Den ikke-autonome patient kan klassificeres under et eller flere af ovenst ende punkter; en patient som besidder evne til at formidle pr ferencer og valg samt s gar at v re i stand til at formulere relevant information, er ikke n dvendigvis nok til, at vi kan kategorisere vedkommende som autonom, for er den ber rte ikke i stand til at opfylde minimumskriteriet, s  kan vi ikke betragte vedkommende som autonom. Dette skyldes, at hver enkelt af de tre punkter; *intention, forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse*, alle er n dvendige, men ikke tilstr kkelige hver is r. En patient kan ikke foretage et autonomt valg, hvis denne ikke opfylder alle minimumskriterier for autonomi. Det er  benlyst, at hvis patienten besidder *forst else* og *intention*, men ikke kan se sig fri af *kontrollerende indflydelse*, indre som ydre, s  kan vedkommendes valg ikke betragtes som autonomt; tvinges patienten til at g re handling-X, s  er det klart, at denne handling ikke er autonom, da patienten ikke er fri til at foretage sit eget  nskede valg – dette g lder ogs  i tilf lde af interne omst ndigheder, hvor vedkommende ikke kan se sig fri af

¹² Childress, James F. og Beauchamp, Tom L: *Principles of Biomedical Ethics*. Side 85

kontrollerende indflydelse. Patienten skal give et rationelt grundlag for sit valg. Er patienten ikke i stand til at g re s danne, s  kan valget ikke klassificeres som autonomt. De syv punkter ovenfor er s ledes et udtryk for, og en indikator af, hvorledes patienten er i stand til at leve op til autonomiens minimumskriterium. Punkterne er derved en m de, hvorp  sygeplejersken kan vurdere patientens evner og kompetencer, hvis grundlag er autonomiens minimumskriterier.

Lad os belyse minimumskriterierne for autonomi lidt n rmere. Begrebet *forst else* er ikke et ubetinget begreb; begrebet kan gradb jes, modsat de to  vrige kriterier; *"An account of understanding that required an extremely high level of understanding would be oppressive if made a condition of autonomy"*¹³. "Vi kan ikke forvente, at patienten kan besidde en fuld ud forst else for situationen, der til er begrebet ganske enkelt for bredt. Dette betyder dog ikke, at patienten, hvis vedkommende vurderes til at besidde egenskaben autonomi, kan se sig fri for ikke at skulle redeg re for en basal forst else. Hvis patienten v lger X frem for Y, m  dette n dvendigvis funderes p  en basal forst else af valget. Patienten m  s ledes vide noget om, hvad valget af X betyder frem for valget af Y, men at patienten ikke har den fulde forst else er ikke nok i-sig-selv til at kategorisere vedkommende som ikke-autonom. At patienten ikke kan redeg re fuldt ud for sit valg af X er ganske enkelt forst eligt; hvis patienten bliver spurgt; *hvorfor valgte du at uddanne dig til skolel rer?* s  virker det ganske enkelt absurd, at patienten fyldestg rende skal redeg re for alle facetter af sit valg. Til geng ld kan et valg uden basal forst else ikke klassificeres som af autonomkarakter; s danne valg vil ikke leve op til autonomiens krav og patienten vil s ledes i sin forklaring af valget ikke v re i stand til at redeg re for valget og derved kan sygeplejersken vurdere, at patientens valg ikke er autonomt.

Den intentionelle handling m  ligesom forst else v re hensigtsm ssig begrundet, men m  samtidig v re af fuld intention og kan derved ikke gradb jes; *"For an act to be intentional, it must correspond to the actor's conception of the act in question"*¹⁴. Hvis sygeplejersken skal vurdere, om patientens valg er autonomt m , der v re kontinuerlig

¹³ Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Side 314-15

¹⁴ Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Side 314

sammenhæng mellem patientens eventuelle formodninger, tanker og ønsker i patientens intention. Dette betyder, at begrebet ikke kan gradbøjes, og der vil altid være en sammenhæng mellem handlingens autonomi og intentionen. Hvis X har intention om at gå til højre men faktisk går til venstre, så er dette grundlag nok til at vurdere, at patientens ikke lever op til autonomiens krav. Ydermere skal patientens ønske om at gå til højre frem for venstre bakkes op af forståelsen for, hvad det vil sige at gå til højre. At have intention om at gå til højre men går til venstre er et tegn på, at patienten hverken har den basale grundforståelse for at vælge højre frem for venstre og samtidig ikke er i stand til at patientens præferencer stemmer overens med intentionen. Er dette tilfældet er patienten ikke autonom i henhold til Beauchamps minimumskriterium for autonomi.

Det sidste forhold, som må tages i betragtning, er ikke så abstrakt som de to øvrige. Skal et autonomt valg foretages, må det funderes på, at patienten kan se sig fri af kontrollerende indflydelse; dette gælder både interne og eksterne konflikter. En patient som lider af tvangstanker er genstand for ufrivilligt at lade sig distrahere af uønskede tanker, som er i stand til at kontrollere vedkommendes liv i så en høj grad, at det har indflydelse på patientens livskvalitet. Når disse uønskede tanker finder sted, kan patienten ikke se sig fri fra at vedkommendes liv er kontrolleret af interne omstændigheder, som gør, at patienten ikke er i stand til at styre sit liv. Er dette tilfældet, kan vi ikke kategorisere patienten som autonom. Det vil sige, at de valg som patienten foretager, mens tvangstankerne finder sted, ikke er af autonomkarakter, og derved kan vi ikke respektere patientens autonomi i situationen, da der ikke er nogen autonomi at respektere. Modsat indre tvang og indflydelse er ydre omstændigheder mere tilgængelige at vurdere; *"Coercion, as we define it, occurs when one person intentionally uses a credible severe threat of harm or force to control another"*¹⁵. Er denne form for tvang tilfældet, er det åbenlyst, at personen, som underlægger den anden tvang, ikke behandler personen som et fornuftsvæsen og derved som mål-i-sig-selv i kantiansk forstand, men til gengæld reducerer den anden til et middel til egne formål.

Intention, forståelse og fri af kontrollerende indflydelse er autonomiens grundvilkår. I daglig praksis kan disse tre begreber og kriterier bruges af sygeplejersken til at vurdere,

¹⁵ Childress, James F. og Beauchamp, Tom L: *Principles of Biomedical Ethics*. Side 107

hvorvidt patientens valg eller  nske er autonomt. Disse principper f lger Kants frihed og autonomibegreb; er patienten, det vil sige fornuftv snet, autonomt, s  er vedkommende i sin ret til at agere som selvlovgivende v sen, og sygeplejersken m  respektere patientens autonomi og v rdighed, ubetinget. Dette betyder, at sygeplejersken m , uanset egen overbevisning, respektere patientens autonome valg, da patienten, i kraft af dets fornuftsm essighed, altid er et m l-i-sig-selv. Lad os belyse dette forhold n rmere ved en case omhandlende en lungecancerpatient som vi kan kategorisere som borderline-autonom¹⁶;

Case

"Patienten fik for 6 m neder siden konstateret lungecancer. Hun kom i  jeblikkelig behandling med kemoterapi, men i forbindelse med kontrol CT efter behandlingen, blev det konstateret, at der nu var metastaser til binyrerne og til skelettet. Grundet problemer med smertebehandling fik patienten bevilliget en korttidsplads i hendes hjem-kommune.

Under flere samtaler p  hospitalet har patienten og hendes datter n gtet at h re p , hvor syg hun er og at der beklageligvis ikke findes en kurativ behandling. Patienten har endvidere ikke villet h re tale om, hun skal terminalerkl res. Hun er dog blevet terminalerkl ret, men vil ikke acceptere dette.

Patientens tilstand forv rres dag for dag, og hun har ulidelige smerter. Hun bliver tilset af det palliative team, men griner af dem og de behandlingstilbud, de har i forhold til en sufficient smertebehandling, og ofte ender samtalerne med, at hun smider dem ud af sin stue p  korttidspladsen. Hendes daglige kontakt best r af kontakt til to sygeplejersker, som fors ger at hj lpe hende s  godt som muligt – hun  nsker ikke hj lp fra andre. De to sygeplejersker har passet mange d ende og er s ledes kl dt godt p  fagligt¹⁷."

Den pligtetiske sygeplejerske st r nu i f lgende dilemma; patientens tilstand forv rres fra dag til dag. Ydermere vil patienten ikke acceptere det faktum, at

¹⁶ Med dette menes der, at det ikke er umiddelbart klart, hvorvidt patienten er autonom eller ej.

¹⁷ Anonym case pr senteret til Klinisk Etiske Komiteer, Aarhus Universitetshospital torsdag d. 2. februar 2012

vedkommende er d ende. I dette forefindes to dilemmaer; 1) patientens smerte vil lindres, hvis vedkommende tager imod tilbuddet om den rette smertebehandling, s ledes at hun ikke vil lide un digt og 2) Patienten skal behandles med v rdighed og respekt, hvilket ikke er muligt, hvis vedkommendes autonomi kr enkes. Sp rgsm let er selvf lgelig, hvorvidt patienten besidder autonomi, eller om sygeplejersken kan vurdere, at patienten ikke g r og derved kan retf rdigg re et paternalistisk indgreb. I henhold til den Professionsetiske Beslutningsmodel indeb rer pligtetikken at sygeplejersken skal tage forbehold til f lgende principper;

- *Respektere autonomi*
- *Behandle retf rdigt*
- *Undg  skade*¹⁸

At respektere patientens autonomi betyder at respektere patientens individualitet og v rdighed. Dette er grundl ggende, da den autonome patient altid er et m l-i-sig-selv. Netop dette, at patienten er m l-i-sig-selv, betyder ogs , at patienten skal behandles retf rdigt; det giver ikke nogen mening at forskelsbehandle patienter, da s danne handlinger vil mods tte sig det Kategoriske Imperativ. Patienten vil v re et middel og ikke et m l, og derved vil s danne handling v re uden moralsk v rdi. At undg  skade vil sige at forhindre, at patienten lider un digt. Det lader sig v re fysisk og psykisk smerte samt ikke at forvolde skade p  patientens v rdighed. I henhold til de Sygeplejeetiske Retningslinjer 2010 skal sygeplejersken *”medvirke til, at patienten modtager og forst r den information, der er n dvendig for at tr ffe valg. Information, der gives, skal v re tilpasset den enkelte patients  nsker og behov samt patientens livssituation*¹⁹. ”Lad os nu analysere den viden vi har om patienten n rmere og hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til denne viden. De to grundl gende informationer vi har er; at patienten samt hendes datter ikke vil anerkende det faktum, at patienten er d delig syg, og at der ikke findes nogen kurativ behandling²⁰. Dertil m  det noteres, at patientens tilstand forv rres fra dag til dag. Det som vi m  sp rge os selv om, i denne komplekse situation

¹⁸ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 187

¹⁹ Sygeplejeetisk r d 2010 §2.2

²⁰ Jeg udelader bevidst at inddrage datteren i den pligtetiske analyse. Dette skyldes, at pligtetikken omhandler det direkte forhold mellem den professionelle og patienten og ikke de indirekte forhold som datteren er en del af.

er, hvorvidt patienten har levet op til det minimumskriterium for autonomi, som p peges af Beauchamp. Vi kan s ledes sp rge os selv f lgende tre sp rgsm l; Har patienten basal forst else for sin situation? Hvad er patientens intention i valget om ikke at ville terminalerkl res samt kan patienten se sig fri fra kontrollerende indflydelse? Min p stand skal lyde, at der er indicier, som peger p , at patienten ikke er klar over, eller rent psykologisk ikke vil indse, situationens definitive omst endigheder. Vi kan stille sp rgsm lstegn ved, hvorfor patienten v lger ikke at ville acceptere sin terminalerkl ring samt ikke at acceptere, samt anerkende, det palliative team som st r r dighed. Det er klart, at forst else for situationen kan gradb jes; vi kan ikke forvente, at patienten besidder liges  meget viden om sin lungecancer som l gen og sygeplejersken. Forst else for situationen er gradb jelig, men da patienten, s  vidt vides, ikke er i stand til at forklare, hvorfor hun ikke  nsker den tilbudte behandling, men blot griner  benlyst af dem og ikke er i stand til at give en rationel begrundelse for sit valg, tyder p , at patienten ikke besidder en basal og n dvendig forst else af situationen. Patientens intention er klar og velformuleret; hun  nsker ikke at modtage behandling. Men, hvis patienten ikke besidder basal forst else for situationen, s  virker det til, at intentionen ikke stemmer overens med det kontinuerlige forhold, som skal v re tilstede i patientens formodninger, tanker og  nsker; for hvis patienten ikke har forst else for situationen, hvordan kan vi s  overhovedet tro, at patientens intention beror p  et rationelt grundlag? Dette lader ikke til at v re tilf eldet. Endelig m  vi sp rge om, hvorvidt patienten kan se sig fri af kontrollerende indflydelse? I dette vil jeg mene, at de psykologiske forhold er vigtige. I dette tilf elde lader det til, at patienten befinder sig i en virkelighed, som egentlig ikke er til. Der lader til at v re nogle indre faktorer, som forhindrer patienten i at indse sin situation, m ske frygt for d den osv.

S ledes kan vi ved brug af Beauchamps minimumskriterium for autonomi vurdere, at denne patient ikke besidder egenskaben, og derved er der ingen autonomi at respektere. Sp rgsm let er, hvad vi i pligtetisk henseende b r g re ved s danne patienter? Vi har konkluderet, at der er grund til at sk nne, at patienten ikke handler rationelt og autonomt; der kan stilles tvivl ved, hvorvidt hun er i stand til selv at tr ffe et valg, som har afg rende betydning for hendes behandling og pleje. Pligtetikken fordrer, at vi m 

respektere et autonomt valg, men da der i dette tilfælde ikke er tale om autonomi, m  vi i stedet vurdere, at patienten skal undg  yderlig skade. I dette tilfælde er der tale om at undg  yderlig indirekte skade, hvilket vil forekomme, hvis ikke et palliative team inddrages til at yde smertelindrende behandling samt hindre, at patientens v rdighed kr nkes. Dog skal patienten behandles retf rdigt; der m  ikke forskelsbehandles. Det vil sige, at patienten ikke m  tilsides ttes eller rangeres lavere end andre patienter, ogs  selv om patienterne er i stand til at foretage et autonomt valg modsat lungecancerpatienten.

Vi kan retf rdigg re et paternalistisk indgreb, da vi har grundlag for at sk nne, at patienten ikke er i stand til at foretage autonome valg. Dog m  vi skelne mellem indgreb, hvori vi forhindrer, at patienten forvoldes yderlig skade og indgreb, hvori vi foruds tter en bedrevidenhed. Sp rgsm let er, hvorledes vi skal forholde os til brugen af paternalistisk indgriben i henhold til pligtetikken og Kants Kategoriske Imperativ? Vi har retf rdiggjort muligheden for indgriben, da der ikke er nogen autonomi at respektere, men dette betyder ikke, at vi kan bruge patienten til de form l, vi nu engang  nsker. N r patienten p tvinges palliative behandling, er sp rgsm let, hvorvidt p tvinges patienten denne brug, fordi institutionen har behov for at frigive nogle midler for at modtage yderlig  konomisk st tte, s  er sindelaget forkert; derved bliver handlingen i kantiansk forstand af manglende moralsk v rdi, fordi patienten bruges som middel, ikke m l. Men patienten m  n dvendigvis p tvinges paternalisme, n r et onde skal forhindres, hvis vedkommende ikke l ngere selv er i stand til at foretage n dvendige autonome valg, som kan forhindre yderlig lidelse – dette er ikke at p tvinge patienten et gode, men at forhindre et onde. Derved kan et paternalistisk indgreb retf rdigg res.

Vi m  dog p pege, at en case som denne med lungecancerpatienten kan v re tvetydig; man kan argumentere for, at patienten rent faktisk er autonom, og derved kan man, if lge pligtetikken, under ingen omst ndigheder kr nke hendes autonomi, da patienten er et m l-i-sig-selv og ikke et middel for de professionelles  nsker og behov. Dog kan vi grundl ggende vurdere, at det kantianske autonomibegreb er en egenskab, som man enten besidder eller ikke g r; man skal redeg re for sine valg, eksemplificeret ved brug af Beauchamp, for at besidde autonomi. I den pligtetiske analyse af lungecancerpatienten m  vi fokusere p , hvorvidt patienten er i stand til at have forst else og intention og se sig

fri af kontrollerende indflydelse, n r vedkommende tr ffer sit valg. Vi m  s ledes vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at give udtryk for egne pr ferencer, at forst  den information som l ger og sygeplejersker har formidlet, og hvorvidt patienten i forl ngelse af dette er i stand til at forst  sin egen relevante situation. Endelig skal patienten v re i stand til at forst , hvad konsekvenserne af en eventuel frav lgelse af behandling har af betydning for hendes relevante sygdomsforl b og situation. Er patienten i stand til dette, s  er vedkommende i stand til at leve op til disse kriterier og derved i stand til at besidde moralsk autonomi; heri er der ikke tale om tilf ldige valg vurderet ud fra tilb jeligheder men valg, som er funderet i en agtelse for moralloven og pligten; derved bliver valget en moralsk handling, som finder v rdi i kraft af, at det m  g lde som en gyldig almen lov – som et kategorisk imperativ.

Fra moralsk til personlig autonomi

Det etiske indhold i Kants filosofi er agtelsen for moralloven og menneskets ubetingede v rdighed. Moralloven er kendetegnet ved sin indre v rdi, hvori fornuften, via autonomi, indser, at pligten i sig selv m  v re tilstr kkelig motiv for at agte og adlyde moralloven. Moralloven p byder, at vores handlinger skal g re sig g ldende som gyldig almen lov. Ved at f lge denne lov kan vi rationelt t nke os til, hvad vores pligt er. I dette skal den enkelte v re i stand til at reflektere og benytte sig af sin egen forstand. Men det er  benlyst, at dette i sig selv ikke er nok. Ganske vidst sikrer det kantianske autonomibegreb fornuftsv snet en r kke rettigheder i kraft af det Kategoriske Imperativ, men det siger ikke noget konkret om det enkelte menneske; hvem er personen bag? Hvilke livsanskuelser og v rdier har den ber rte? og s  videre. Vi har derfor behov for et autonomibegreb, som siger noget om det enkelte menneske. Dette er n dvendigt i sygeplejen, da dette giver et grundlag for at yde en patient-tilpasset pleje og behandling af hver enkelt patient. Skal sygeplejersken v re i stand til at afg re, om patienten i helhed er autonom, s  kr ver det mere end blot at analysere de valg, som vedkommende foretager. Det kantianske autonomibegreb siger ikke, hvorledes sygeplejersken skal forholde sig til patientens personlige autonomi; i m det med den anden kan

sygeplejersken, ved pligtetikken, ikke finde noget svar, andet end hun n dvendigvis m  respektere patientens autonomi og v rdighed. Men patienten er et menneske, som ogs  har en baggrund, livserfaring og v rdier, som ikke kan medbetragtes i kantiansk perspektiv. Der mangler et grundlag, hvori sygeplejersken kan tage udgangspunkt i pleje og behandling af patienten. Hvis patienten, i kantiansk optik, er autonom, og vedkommende  nsker X frem for Y, s  kan dette  nske ikke tilsides ttes, da dette vil v re at kr nke patienten. Ganske vidst kan sygeplejersken antage, at dette  nske er et autonomt valg, men hun kan ikke vide, hvorvidt patientens  nske stemmer overens med valg af v rdier og livsanskuelser. Er patienten et Jehovas vidne, som i behandlingen og plejen ytrer, at vedkommende gerne vil modtage blod, s  kan dette valg v re autonomt, men der forekommer en kontradiktion mellem patientens autonome valg og patienten som autonom person i s danne tilf lde. Hertil m  sygeplejersken stille sig kritisk, og hun har derfor behov for et bredere redskab end d t som tilbydes ved Beauchamps minimumskriterium for autonomi. At besidde personlig autonomi betyder at v re i stand til at v lge v rdier og st rre valg, som har indflydelse p  det liv, man nu engang v lger at leve. Der skal v re en rationel forbindelse mellem disse, hvilket  benlyst ikke kan v re tilf ldet med Jehovas vidne patienten, da der er modstridende forhold mellem vedkommendes autonome valg og personen som et autonomt individ med livsindhold og anskuelse, som vedkommende selv har valgt.

Ovenst ende eksempel er m ske af sj lden karakter, men det viser, hvorfor sygeplejersken skal have et redskab til at forbinde det autonome valg med den autonome person. Sygeplejersken har, i pligtetikken henseende, pligt til at respektere patientens autonomi og behandle vedkommende retf rdigt. Dette fordres via moralsk autonomi, som opstiller, via Kants autonomibegreb, disse principper, og sygeplejersken har pligt til at leve op til disse principper. Men p  den anden side skal sygeplejersken ogs  bidrage til, at patienten kan besidde evnen til selvbestemmelse. Og det er netop ved denne overgang, at vi har brug for endnu en teori, som kan g re, at vi kan g  fra moralsk autonomi til personlig autonomi, hvori sygeplejersken skal vurdere patientens valg af v rdier og inddrage disse i plejen, s ledes at patienten kan f  de bedst mulige foruds tninger i sit sygdomsforl b. For at v re i stand til dette skal sygeplejersken have et indblik i

patientens koh rente pr ferencesystem, hvor hun kan kategorisere patienten som autonom og ikke kun valget.

Filosoffen Laura Waddell Ekstrom kan give sygeplejersken redskabet til dette. Jeg har valgt at kategorisere Ekstroms position som konsekvensbetragtende. Dette g r jeg, da hendes koh rensteori bruges til at klarg re, hvorledes sygeplejersken kan vurdere patientens evne til selvbestemmelse og i visse tilf lde m  vurdere, hvilken behandling og pleje, der vil v re den bedste med henblik p  at fremme patientens selvbestemmelse²¹.

Ved brug af begrebet tilf jer Ekstrom den filosofiske autonomidiskussion et nyt begreb; pr ference. Ved brug af pr ferencer kan den enkelte, det vil sige patienten, udtrykke en kritisk vurdering af, hvad vedkommendes definition af det gode er. Dette betyder en kritisk stillingstagen i henhold til de valg og v rdier, patienten har valgt i sit liv. Dette kan v re et  nske eller  nsket om at have et  nske – men det som kendetegner pr ferencebegrebet er ikke, hvad det som s dan er rettet imod men den proces, hvorigennem pr ferencen er blevet til. Ved kritisk stillingstagen til valg af v rdier v lger det enkelte autonome menneske selv sine v rdier – deraf personlig autonomi. At v lge en v rdi eller pr ference kan ikke v re autonom, hvis dette valg ikke har v ret under kritisk evaluering af den ber rte person selv. Det afg rende ved dette er, at det er personen selv, som har valgt at v lge denne pr ference. Den moralske autonomi kan ikke v lge X frem for Y, da valget allerede er forh ndsbesluttet. Men ved brug af personlig autonomi kan man v lge X, da dette vil passe ind i egen definition af det gode og personens helhedsbillede s ledes, at dette stemmer overens med vedkommendes personlige autonomi.

Det som kendetegner dette valg af pr ference er, at der er tale om sammenh ng mellem det  nskede valg og den person, som valget begrundes i. Valget grunder derved i en langt bredere autonomi forst else, da der er tale om et personligt karaktersystem, hvori sygeplejersken skal v re i stand til at vurdere, hvorvidt patientens valg stemmer overens med patientens personlige autonomi og koh rente pr ference system. I introduktionen til essay samlingen *Personal Autonomy – New Essays on Personal*

²¹ L ser bedes v re opm rksom p , at jeg ikke bruger Ekstroms filosofi som en konsekvensutilitaristisk etisk position men som en konsekvensbetragtende position.

Autonomy and Its Role in Contemporary Moral Philosophy beskriver James Stacey Taylor brugbarheden af Ekstroms teori p  f lgende m de;

"...by bashing her coherentist analysis of autonomy on the insight that if a person is to be autonomous with respect to a preference, that preference must originate from that person's self in a particular, objective way"²².

Det er p  denne m de, vi skal forst  Ekstrom og forholdet mellem personlig autonomi og selvbestemmelse, n r vi i det f lgende afsnit belyser forholdet herimellem; sygeplejersken skal v re i stand til at vurdere patientens autonomi i henhold til et l ngere sigtede perspektiv end blot det autonome valg. For at yde bedst mulig pleje og behandling skal hun have indsigt i, hvem den enkelte patient er for at v re i stand til eventuelt at bidrage til at fremme denne patients evne til selvbestemmelse. Dette kan ikke lade sig g re, hvis vi blot bruger Beauchamps minimumskriterium, da det at ud ve autonome valg i sig selv er nok til at blive kategoriseret som autonom i praksishenseende. I det f lgende afsnit vil vi se, hvorledes sygeplejerskens indsigt i patientens personlige autonomi g r, hvis denne er til stede, at hun har et redskab til at bidrage til at patientens selvbestemmelse fremmes.

Selvbestemmelse og personlig autonomi – et konsekvensbetragtende perspektiv

I henhold til Kant er en person autonom, hvis vedkommende kan p l gge sig selv at leve efter moralloven. Det vil sige at v re i stand til at tr ffe valg, hvis grundlag udelukkende er funderet p  rationalitet uden indflydelse af tilb jeligheder. Men sp rgsm let er, om dette kantianske autonomibegreb ikke er for begr nset? Og dertil m  vi sp rge, om ikke Kant, b de i teori og i praksis, som anvendt ved Beauchamp, foruds tter, at vi v lger og tr ffer vores moralske og autonome valg p  baggrund af en allerede p  forh nd givet faktor, som g r, at vi ikke medt nker de eksterne omst ndigheder, som spiller ind, n r vi skal foretage et autonomt valg? Den kantianske

²² Taylor, James Stacey: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*, Introduction. Side 15

teori har allerede forudbestemt, hvad der er rigtigt og forkert uden at tage hensyn til de eksterne begr nsninger, som vi, som sociale v sner, altid er underlagt. Det vil sige, at den moralske autonomi, som er udgangspunktet for Kants moralteori, ikke inddrager hverken sociale, psykologiske eller s gar biologiske faktorer, som n dvendigvis m  inddrages, hvis vi skal vurdere, om en person er autonom eller ej. Det kantianske autonomibegreb kan forekomme for begr nset, n r vi skal tale om det autonome menneske. Hertil er det vigtigt at have in mente, at vi m  skelne mellem det autonome valg og den autonome person. Beauchamp belyste, hvorledes vi kan kategorisere en persons valg som autonomt, hvis vedkommende levede op til autonomiens minimumskriterium. Men derved kan vi ikke udelukkende bruge Beauchamps kantianisme til at vurdere, om en person er autonom. For hvis vi skal vurdere, om personen, ikke valget, er autonomt, m  vi have en bredere forst else af begrebet autonomi. S ledes m  vi bev ge os v k fra tanken om mennesket som et isoleret subjekt for derimod at t nke det ind i et st rre sammenh ng, hvori det ikke ser sig begr nset til udelukkende at handle efter forudsatte moralske forpligtelser. Vi m  skelne mellem det kantianske autonomibegreb og et bredere selvbestemmelsesbegreb, hvori der gives plads til det enkelte menneskes livssyn og livsforst else. Med dette in mente vil vi se, at autonomi ikke er et begreb, som kan st  selvst ndigt; det bliver reduceret til  n blandt flere facetter af et bredt selvbestemmelsesbegreb.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer henviser til at; *"Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at frav lge selvbestemmelsesretten"*²³. "samt at *"Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin v rdighed og integritet"*²⁴. " men f r sygeplejersken kan medvirke til, at disse kriterier bliver opfyldt, kr ver det, at patienten er i stand til at besidde en acceptabel og fyldestg rende kontrol over sit eget liv. Det vil sige at v re i stand til leve og agere i sit liv p  s danne m de, at man har forst else for de valg, man foretager i livet. Her t nkes ikke p  almindelige dagligdagsbeslutninger men valg, som har en betydelig indvirkning p  det liv, man nu engang har valgt at leve. F r dette er muligt, m  og skal patienten stadig leve op til autonomiens minimumskriterium, men vi m  n dvendigvis tilf je et ekstra kriterium; et

²³ Sygeplejeetisk r d 2010.  2.3

²⁴ Sygeplejeetisk r d 2010.  2.4

refleksiv selv hvis valg er meningsfyldte og koh rente og derved foretaget i egenskaben af at v re en autonom person.

Det kan dog forekomme problematisk at vurdere, hvorn r sygeplejersken skal *respektere patientens valg*, samt hvorn r det giver mening at tale om, hvorledes en patient kan bevare sin *v rdighed og integritet*. Laura Waddel Ekstrom udarbejder i sit essay *Autonomy and Personal Integration* en *koh rensteori*, som giver et svar p , hvorn r vi kan betragte den enkelte patient og det enkelte menneske som autonom. Ekstroms tilf jer, at der n dvendigvis m  v re et refleksivt lag i autonomien; et lag som grundl ggende er skabt af jeget selv. S ledes skriver Ekstrom;

*"Motivated, in part, by reflection on particular and motivated, as well, by the problem of regress for hierarchical accounts, a coherence approach to autonomy specifies that the preference on which a person acts must cohere with other of his other attitudes, in order for the act to be autonomously performed."*²⁵

For at vurdere en patients evne til selvbestemmelse, m  vi inddrage det refleksive lag, som ikke er til stede hverken hos Kant eller i Beauchamps praksisanvendelse af autonomibegrebet. Denne ekstra tilf jelse g r, at vi m  se p  personen og ikke valget, n r en patient skal vurderes som autonom; dertil m  vi bruge begrebet pr ference. Dette begreb skal ikke forst s i almen forstand, men som et  nske, hvori en kritisk vurdering har fundet sted; herfra bev ger vi os fra et  nske, eller  nsket om at have et  nske, til selve processen. Hvis en patient ytrer, at vedkommende ikke  nsker behandling, eksempelvis grundet religi s overbevisning, skal sygeplejersken vurdere, hvorvidt dette  nske passer ind i patientens livsanskuelser og pr ferencer. I s danne ytring findes patientens egen forestilling om *det gode*; hvilket vil sige patientens subjektive forst else af, hvad der er *det gode* og sande og ikke n dvendigvis, hvad den videnskabelige definition af *det gode* er. Dette betyder, at anvender vi Ekstrom i etik i sygeplejen, kan vi redeg re for, hvorfor eksempelvis en patient, som lider rent eksistentielt, ikke kan betragtes som autonom; opfylder patientens  nske ikke det subjektive kriterium for forst elsen af *det gode*, hvori vores handlinger skal skabes, giver dette  nske ikke nogen mening, og derfor m 

²⁵ Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration*. Side 144

sygeplejersken gribe ind ved paternalisme, s ledes at patienten ikke tr ffer et valg, som er funderet i den eksistentielle lidelse, men derimod fors ge at hj lpe patienten til at lindre sin lidelse – det vil sige at afv rge et onde. Dette kan lade sig g re ved, at sygeplejersken vurderer patientens livsanskuelser og pr ferencer og derved kan tr ffe et valg om, hvilken behandlings- og plejeform denne specifikke patient har behov for. Det vil sige, at sygeplejersken skal vurdere patientens karaktersystem og identitet, og hvilke pr ferencer disse best r i. Heri er pr ferencer de  nsker, som patienten har truffet p  baggrund af reflektiv og kritisk vurdering i sin s gen efter det subjektive gode. Dermed bliver patientens karaktersystem det grundlag, som konstituerer dennes selv. Dette m  sygeplejersken have i mente, n r hun skal leve op til kravet om at respektere patientens integritet og v rdighed; sygeplejersken skal vurdere patientens evne til at tr ffe valg, som er forenelige med patientens egne v rdier (derved skelnen mellem det autonome valg og den autonome person), som forefindes i patientens integrerede selv. Dette kr ver, at patienten selv skal v re i stand til at redeg re for sin selvbestemmelse, hvori vedkommende skal begrunde sine valg i et v rdisystem, hvori patienten har sine overbevisninger og pr ferencer. Det vil sige, at foretager patienten et valg, som har indflydelse p  vedkommendes livskvalitet og anskuelse, s  m  patienten foretage dette p  baggrund af egne pr ferencer – det er patientens dybere selv, som accepterer og redeg r for dette valg, alts  noget som er integreret i selvet. Derved kan den professionelle sygeplejerske, i vurdering af patientens autonomi og selvbestemmelse, kr ve, at patienten lever op til f lgende tre punkter;

- *Has undergone critical evaluation with respect to his conception of the good*
- *Was uncoercively formed*
- *Coheres with his other acceptance and preferences states*²⁶

Opfylder patienten disse kriterier, s  kan vedkommende give et sammenh engende forhold af sine pr ferencer og v rdier, og derved er der koh rens mellem patientens eget v rdisystem og grundlag samt patientens integrerede selv; *"On the coherence account, a preference P is personally authorized for a person at a time(or counts as 'truly her own' or is a representative of her 'real self') if and only if the preference coheres*

²⁶ Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration*. Side 154

*with her character system at that time*²⁷. "Ved dette giver det mening at tale om et bredere autonomibegreb – et begreb som danner grundlag for patientens selvbestemmelse. Dette betyder s ledes ogs , at patienten skal leve op til det brede krav om autonomi, som vi finder i selvbestemmelsesbegrebet. Og for at sygeplejersken kan leve op til Sygeplejeetisk R ds retningslinjer om at behandle og *arbejde for, at patienten bevarer sin v rdighed og integritet* samt vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at handle, s ledes at vedkommende kan g re krav p , og frav lge, selvbestemmelsesretten, m  sygeplejersken samt  vrige professionelle have en formodning og antagelse af patientens koh rente pr ferencer og v rdier, s ledes at man kan opn  bedst mulig behandling og pleje, hvorved v rdighed og integritet bevares; "A third-person perspective, as well, may be mistaken concerning whether an attitude is part of someone's real self, depending on the extent of one's knowledge of the other's character. That is, one must have sufficient knowledge concerning about another's collection of evaluatively formed attitudes, in order to know if a given preference coheres with them"²⁸. " Analyserer vi lungecancerpatienten i koh rensteoriens optik, vil behandlingen og plejen af patienten v re fokuseret p  et andet felt, end hvis vi udelukkende g r brug af Kants autonomibegreb praktiseret af Beauchamp. Ved brug af Ekstrom kan vi fokusere p  konsekvenserne af behandlingen; antager vi en patient, som ikke besidder autonomi, men til geng ld besidder en hvis grad af selvbestemmelse, eksempelvis lungecancerpatienten, hvis psykiske tilstand g r, at hun ikke er i stand til at tr ffe autonome valg i det specifikke sygdomsforl b, kan vi arbejde p  at fremme patientens selvbestemmelse og derved bidrage til, at hun p  sigt vil v re i stand til at besidde et bedre r derum over egen tilv relse. Det er klart, at patientens ustabilitet g r, at hun m ske ikke helt form r at overskue konsekvenserne af et givet valg, men dermed ikke sagt, at hun ikke kan (med)bestemme over sit eget valg; ved at fremme selvbestemmelse hos patienten fordres der til en medvirkende af udvikling, som sigter efter, at patienten p  et tidspunkt vil v re i stand til at udf re et autonomt valg, som passer ind i hendes selvbestemmelsesforl b; det vil sige passer ind i det integrerede selv, og derved kan der s ttes lighedstegn mellem patientens valg og pr ferencer, s ledes at

²⁷ Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration*. Side 151

²⁸ Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration*. Side 158

der er tale om et koh rent forl b, som stemmer overens med patientens v rdier, livsanskuelser og integrerede selv. At fremme selvbestemmelse er s ledes en konsekvensbetragtende position, hvori man vurderer konsekvenserne af behandlingen og plejen, og man medinddrager patienten for at vurdere, hvad der er bedst for vedkommende. At fremme selvbestemmelse er s ledes en beregnende kalk le mellem autonomi, hvori den enkelte er i stand til at v lge selv, og paternalisme, hvori eksempelvis formynderisk omsorg kan forekomme²⁹.

Med dette in mente kan vi bruge Ekstroms teori til at vurdere, hvorvidt en person er autonom. Er der sammenh eng mellem patientens  nsker og pr ferencer, og stemmer disse overens med personens v renssl gtskab, s  m  patienten kategoriseres som autonom i kraft af, at disse stemmer overens med personens integrerede selv. Men i praksis er dette s ledes ogs  en kompleks teori, fordi der skal medtages et langt bredere perspektiv end ved det kantianske minimumskriterium for autonomi. Men dette brede perspektiv er n dvendigt, hvis sygeplejersken skal v re i stand til at vurdere patientens evne til selvbestemmelse samt besiddelse af autonomi. I vurderingen af lungecancerpatienten kan vi ikke n jes med at vurdere *intention*, *forst else* samt *fri af kontrollerende omst ndigheder*; vi m  s ledes ogs  se p , hvem personen bag patienten er, og hvad baggrunden er, for at hun ikke vil terminalerkl res og derved ikke vil erkende den sidste fase af sygdomsforl bet. Patienten har valgt ikke at lade sig terminalerkl re – dette har dog medf rt et paternalistisk indgreb fra de ansvarshavendes side, hvorved patienten modvilligt er blevet terminalerkl ret – patientens valg, hvis de professionelle skal respektere dette, skal funderes p  det kantianske minimumskriterium. Derudover kan vi stille sp rgsm lstegn ved, hvorvidt patientens valg stemmer overens med vedkommendes komplekse v rdisystem og pr ferencer. Sygeplejersken m  sp rge indtil, hvorvidt patientens valg g r i sp end med  vrige pr ferencer, som er grundlaget for patientens personkarakter og livsanskuelser. I henhold til Ekstroms teori skal lungecancerpatientens valg stemme overens med hendes integrerede selv; dette selv skal s ledes give accept for at foretage dette valg. Dette betyder, at patienten skal redeg re for samt v re i stand til at bakke op om sit  nske om ikke at lade sig terminalerkl res.

²⁹ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 149

Patientens autonomi er s ledes at finde i valget af pr ferencer og helhedsbilledet heraf – ikke i det enkelte valg. Lungecancerpatienten skal godkende og acceptere sine  nsker af sit selv. Dette skal sygeplejersken og  vrige professionelle have in mente, n r de skal varetage behandling og pleje af s danne patient.

Grundl ggende giver Ekstroms teori sygeplejersken mulighed for at behandle en patient med v rdighed og integritet og samtidig vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at besidde retten til selvbestemmelse. Vi kan i tilf lde af lungecancerpatienten s tte sp rgsm lstegn ved, hvorvidt patienten har basal forst else for sit valg samt kan se sig fri af kontrollerende psykologiske omst ndigheder. Dertil kan vi tilf je, at patienten (samt hendes datter) ikke er i stand til at bearbejde den tilg engelige information, hun er blevet informeret om af de professionelle i tilstr kkelig grad, samt at patienten ikke er i stand til at argumentere for sit valg om ikke at ville terminalerkl res samt ikke at redeg re for sin afvisning af det palliative team. Der er s ledes grundl ggende faktorer, som g r, at sygeplejersken kan vurdere, at patienten ikke er autonom. Og for at ville patienten det bedst mulige, m  sygeplejersken herefter arbejde p , at patienten stadig kan bevare sin v rdighed og integritet. Derfor m  vi igen bev ge os tilbage til selvbestemmelsesbegrebet og anskue, hvad der er bedst for patienten. For at finde ud af dette, m  sygeplejersken vurdere patienten med et udgangspunkt i koh rensteorien, hvori hun vil bidrage til, at patienten, forudsat muligheden for det, kan, som tidligere n vnt, bruge en beregnende kalkule i forholdet mellem autonomi og paternalisme og derved fremme patientens selvbestemmelse; *“Sygeplejersken skal medvirke til, at patienten modtager og forst r den information, der er n dvendig for at tr ffe valg. Information, der gives, skal v re tilpasset den enkelte patients  nsker og behov samt livssituation³⁰.”* F rst n vnte kan ikke lade sig g re, da vi har vurderet, at patienten ikke er autonom. Opgaven lyder nu p  at fremme patientens selvbestemmelsesevne; dertil m  vi se p  den sidste del af §2.2, hvori sygeplejersken skal v re i stand til at tilpasse patientens  nsker og behov. I dette tilf lde vil det ikke give nogen mening at tilpasse patientens  nske om ikke at samarbejde med det palliative team, da dette vil betyde, at sygeplejersken ikke vil v re i stand til at leve op til fordringen om at lindre lidelse. Men

³⁰ Sygeplejeetisk r d 2010. §2.2

derved ikke sagt, at sygeplejersken ikke kan leve op til fordringen om at tilpasse patientens behov samt livssituation; derved skal sygeplejersken endnu en gang mobilisere sit fokus p  konsekvensen af, hvad det vil sige at fremme patientens selvbestemmelse; sygeplejersken m  dertil vurdere patientens koh rente pr ferencer og livsanskuelser for derefter at fors ge at behj lpe patienten med at besidde, empower og forst  flere facetter af begrebet selvbestemmelse.

Det f rste, sygeplejersken skal have in mente, er vurdering af patientens *selvansvarlighed*, og hvorvidt vedkommende er i stand til at vedligeholde denne facet. At ud ve selvansvarlighed vil sige at v re i stand til at danne egne m l og handleplaner samt det faktum at v re i stand til at virkeligg re disse³¹. S ledes bliver selvansvarlighed et sp rgsm l om at leve op til det ansvar, man har over for sig selv og derved respektere sig selv. I dette forefindes sp rgsm let om at v lge; de fleste mennesker er i stand til at v lge, nogle mere end andre, og i dette ligger det eksistentielle incitament, som driver mennesket; at foretage valg fordi man har et ansvar for sig selv og det faktum, at man umiddelbart er bedrevidende ang ende, hvad der er bedst for egen person. Samtidig kan man v lge ikke at v lge; det vil eksempelvis sige at frav lge egen selvbestemmelsesret; er patienten bevidst om, hvad det vil sige at frav lge sig dette, s  er dette at have ansvar for sig selv velvidende, at den ber rte ikke umiddelbart selv kan vurdere eller efterleve, hvad der er bedst, og derved v lger vedkommende at frasige sig retten til selv at v lge. I denne frav lgelse bevarer patienten s ledes sin selvansvarlighed, da vedkommende autonomt v lger at frav lge sig retten til selv at bestemme; derved bevarer patienten s ledes sin v rdighed, da patienten, grundet valget, forbliver et m l-i-sig-selv, et menneskeligt subjekt, og ikke reduceret til et objekt, som tilf eldet vil v re, hvis sygeplejersken v lger ikke at inddrage den autonome patients ret til at frav lge sig selvbestemmelsesretten og derved beg  formynderi mod patienten.

I tilf elde af at patienten ikke er bevidst om sin selvansvarlighed, det vil sige, hvis patienten ikke selv er i stand til at v lge eller v lge ikke at v lge, lever patienten ikke op til autonomiens minimumskriterium, da dette indikerer, at vedkommende ikke har basal forst else for situationen. Derudover kan vi stille sp rgsm lstegn ved kriterierne intention

³¹ Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 54

og fri af kontrollerende omst ndigheder. Dette er problematisk i kantiansk forstand, da dette betyder, at der i patientens foretagende vil v re tale om naturlige tilb jeligheder og derved tilf ldigheder; man lever s ledes ikke op til fornuftens kriterium, hvori den enkelte er i stand til at foretage v rdifulde valg og beslutninger. Dette betyder s ledes ogs , at patienten heller ikke kan ud ve selvbestemmelse, da vedkommende ikke er i stand til at v lge sine valg, hvilket f rer til, at denne ej heller er i stand til at ud ve selvbestemmelsesbegrebets anden facet; *selvstyre*.

At ud ve selvstyre vil sige at v re bevidst om egne m l og v rdier. Den enkelte m  selv v lge sine valg, inklusiv v rdier, idealer, projekter og det faktum at v re i stand til at etablere relationer til andre mennesker³². I forl ngelse af Ekstrom er det via selvstyre, at man skaber sig selv, via valg af v rdier og pr ferencer. Derved bliver vedkommende, som er i stand til at ud ve selvstyre, i stand til at begrunde sine v rdier og valg. Derved sammenh ngen med selvansvarlighed da pr ferencevalg skal give mening med det ansvar, man har over for sig selv og sin identitet. Man bliver s ledes til et bestemt individ med bestemte livsanskuelser og indhold, og derved besidder man grunde for at v lge v rdi-x frem for v rdi-y, da det at v lge en handling eller v rdi, som ikke er kompatibel med ens integrerede selv, det vil sige ens koh rente pr ference system, vil v re at svinge sine idealer og v rdier og derved svinge sig selv. For at undg  disse pr ferencekontradiktioner kr ver det netop at besidde, samt forst , de muligheder et eventuelt pr ference valg har p  de v rdier og forpligtelser, som man har skabt i sit livsforl b. Dette f rer til den sidste facet i evnen til selvbestemmelse; at v re i stand til at besidde evnen til *selvudvikling*.

Selvudvikling er evnen til at indrette sit liv efter specifikke m l og v rdier;
*"Selvudvikling er den proces, hvorigennem man n r frem til en vis afklaring af sine m l og v rdier – af hvad man finder v rd at v re, v rd at g re og v rd at opn  i livet. Den er kompleks (forskelligartede relationer og aktiviteter) og livslang"*³³. At processen er livslang betyder ogs , at for at ud ve selvbestemmelse skal man v re i stand til, via proces, at komme frem til ens egne v rdier og pr ferencer; det vil sige b de at v re i stand til at

³² Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 55

³³ Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 56

realisere, s  vidt muligt, den handlen det kr ver at opn  et m l og have en forst else og afklaring for, hvorvidt disse m l og v rdier passer ind i ens koh rente pr ferencer. Men da processen er udsp ndt over l ngere tid, en livsproces, s  kr ver det, at man har indsigt og forst else af egne v rdier, mulige valgmuligheder og derved at indrette sit liv efter forskellige omst ndigheder. Rammes en person eksempelvis af alvorlig sygdom, s  kan dette, b de direkte og indirekte,  ndre personens familieforhold, og man m  derfor ogs  v re i stand til at forst  sig selv, samt sin familie, underlagt disse nye og uventede omst ndigheder – derefter m  man forholde sig til sin sygdom og de familiem ssige omst ndigheder efter ens pr ferencesystem og finde ud af, hvilke handlinger og g ren er autoriserede pr ferencer (det integrerede selv).

Disse tre facetter for selvbestemmelse inkluderer ogs  autonomi. Men i og med at vi skal forst  den enkelte patient som en del af et st rre sammenh ng, eksempelvis familie, s  forbliver autonomi p  lige fod med de  vrige facetter og er derved ikke h vet over disse. Facetterne h nger holistisk sammen og kan ikke blive anskuet rent isoleret set.

I henhold til etik i sygeplejen er det, m  vi notere os, at sygeplejersken har et ansvar for at fremme patientens selvbestemmelse samt at lindre patientens lidelse; men for at v re i stand til dette, m  sygeplejersken forst , og s tte sig ind i, patientens definition af det gode, p  trods at dette m ske adskiller sig fra, hvad sygeplejersken selv anser som det gode. Og s  l nge at patienten er i stand til at argumentere og ud ve selvbestemmelse, s  m  sygeplejersken n dvendigvis respektere patientens  nske og definition af det individuelle gode.

Lad os endnu engang sp rge om hvorvidt patienten er autonom? Som indikeret tidligere lader det sig v re ganske sikkert, at vedkommende ikke er en autonom person, som er i stand til at ud ve selvbestemmelse. Dette skyldes, som n vnt, at vi kan stille sp rgsm lstegn ved, hvorvidt der er en sammenh ng mellem patientens  nsker og integrerede selv. Dette forhold kan ydermere udpensles i patientens manglende evne til at besidde selvansvarlighed – da patienten n gter at h re tale om sin kritiske tilstand, beskadiges hendes evne til at danne realistiske m l og handleplaner, hvilket betyder, at patienten ikke er bevidst over egne m l og v rdier og derved ej heller er i stand til at

ud ve selvstyre. S ledes kan patienten heller ikke v re i stand til at udf re selvudvikling, da hendes manglende valg af modtagelse af behandling fra det palliative team g r, at selvudviklingen obstrueres, da vi m  antage, at patientens manglende evne til at foretage begrundet valg g r, at dette ikke stemmer overens med hendes specifikke m l og v rdier. Grundl ggende kan vi vurdere, at patienten hverken er autonom eller i stand til at ud ve selvbestemmelse. Derfor m  sygeplejersken, for at bevare patientens v rdighed og integritet, hj lpe til med at fremme patientens selvbestemmelse, det vil sige at agere som et hj lpemiddel for patienten, hvorved hun i sidste ende gerne skulle v re i stand til at tr ffe sine egne valg – valg som lever op til Ekstroms teori om et integreret selv; at tr ffe refleksive valg begrundet gennem kritisk vurdering og begrundelse. Dertil m  anvendes en konsekvensbetragende utilitaristisk etik, som kan medvirke til at foreskrive en etik, vis m ls tning, i denne henseende, at regulere patientens adf rd og forst else evne; at hj lpe patienten til at forst  sin situation og derved tr ffe egne valg p  baggrund af en velbegrundet og professionel informations formidling, hvorved patienten, i sidste ende, skal v re i stand til at indg  informeret samtykke. For at begrunde s danne samtykke, hvorved patientens bedste er et absolut m l, bliver det konsekvensbetragende princip s ledes til et sp rgsm l om, hvorvidt den professionelle kan skabe et grundlag for, at patienten kan opn  st rst mulig lykke. Dette princip er lig Ekstroms princip om det gode for den enkelte. Den engelske filosof John Stuart Mill beskrev i v rket *Utilitarisme* fra 1863 den utilitaristiske doktrin p  f lgende m de; *”Den utilitaristiske doktrin er, at som m l er lykke  nskv rdigt, og det eneste  nskv rdige – alt andet er kun  nskelig som middel til et m l”*³⁴. Dette adskiller sig markant fra Kants morallov, da det konsekvensbetragende princip forebygges p  konsekvensen, hvorved motivet eller s gar den enkelte handling i sig selv er irrelevant. Form let er rent teleologisk; i dette tilf lde at fremme patientens evne til at ud ve selvbestemmelse. At fremme lungercancerpatientens selvbestemmelse vil sige at respektere hendes koh rente pr ferencer og integrerede selv. Og det eneste som kan retf rdigg re og bevise, hvad der er bedst for lungecancerpatienten, er det faktum, at hun rent faktisk  nsker det. Men da patienten i Ekstroms autonomidefinering ikke er autonom, da hun ikke har et sammenh engende koh rent system, m  den professionelle foretage sin handling p  et rationelt og

³⁴ Mill, John Stuart; *Utilitarisme*. Side 53

begrundet grundlag, hvorved hun inddrager patientens livsanskuelser (de anskuelser og pr ferencer som sygeplejersken vurderer, at patienten har haft f r forn gtelsen af de kritiske omst ndigheder) s ledes, at patienten kan behandles med v rdighed og integritet. En mulig anvendelsesmodel hvorved vi, muligvis, kan fremme patientens selvbestemmelse, og derved undg  en direkte brug af paternalisme er at g re brug af *Voksen-ung-modellen*, som kan agere bistand til patienter, som er moralske demoraliserede og ikke i stand til at besidde en selvbestemmelse evne; "*Det er mennesker, der p  den ene side form r at tr ffe egne valg, men hvis v rdier, holdninger og ikke mindst evne til selv er s  mangelfuld, at valgene ofte skader b de deres egen og andres menneskers bedste interesse og velv rd*"³⁵. Jeg vurderer, at denne model kan bevirke en positiv effekt p  lungecancerpatienten, da hun stadig er fungerende som mennesket – forst et p  den m de, at det lader til, at hun stadig kan tr ffe valg og v re autonom, s  l nge at det g lder facetter, som ikke ber rer hendes sygdomsforl b. At patientens v rdier, holdninger og manglende evne til at forst  den kritiske situation g r s ledes, at ikke mindst patienten selv, men ogs  andre personer lider skade, eksempelvis datteren, som heller ikke er autonom, da det ikke at tr ffe – eller overveje – et valg g r, at b de patienten og de ber rte parter interesser og velf rd ikke im dekommes. Ved Voksen-ung-modellen kan sygeplejersken medvirke til, at patienten p  sigt kan tr ffe egne valg, og derved lever den professionelle ogs  op til fordringen fra De Sygeplejeetiske Retningslinjer  2.2 om at *medvirke til, at patienten modtager og forst r den information, der er n dvendig for at tr ffe et valg*. Denne information bliver gennem Voksen-ung-modellen mulig at videregive til patienten, hvilket sker p  et grundlag, hvorved informationen er tilpasset den enkelte patient og dennes definition af det gode. Lykkedes dette, kan vi s ledes tale om, at sygeplejersken, via p dagogik, langsomt, men sikkert, giver patienten et ansvar i og for behandlingen. Der er s ledes tale om en videregivelse af ansvar, hvorved sygeplejersken kan vurdere, via Ekstroms teori, hvorn r patienten er i stand til at fremme egen selvbestemmelse og derved v re i stand til at tr ffe et autonomt og begrundet valg. S ledes er der ogs  tale om brugen af det konsekvensbetragende princip om st rst mulig lykke; i dette tilf lde for den enkelte patient, hvorved sygeplejersken ikke beg r paternalistisk formynderi, da denne

³⁵ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 147

‘overdrager’ lungecancerpatientens autonomi og selvbestemmelse p  et teleologisk og sikkert grundlag, hvorved der tages ansvar for patienten p  en v rdig og integreret m de.

Lykkedes Voksen-ung-modellen kan vi ogs  begynde at tale om den Professionsetiske Beslutningsmodels  vrige konsekvens kriterier; at forebygge negativ sundhed, det vil sige at forebygge sygelighed, og lindre lidelse. At forebygge negativ sundhed lader i dette aspekt sig v re umuligt, da kr ften er p  et meget kritisk stadie, hvor man er klar over, at d den er den eneste udvej. Derfor giver det ingen mening at belyse dette kriterium, da dette ej heller kontradikterer med nogle af de  vrige punkter i hverken konsekvensetikken eller pligtetikken. Til geng ld lader det til, at fordringen om at lindre lidelse ikke er opfyldt. I belysningen af dette m  vi skelne mellem forskellige former for lidelse; den umiddelbare fysiske lidelse hvor patienten lider af en kropslig udfoldelses begr nsning, hvori det kan forekomme besv rligt at f  hverdagslivet til at fungere p  lige fod med ens  vrige medmennesker. Derudover kan en patient lide af psykisk lidelse. Eksempelvis en nerv s lidelse eller andre lidelser, hvis symptomer findes i gradb jelig forstand i alle mennesker, s som tvangstanker, nedsat hum r, alkohol forbrug osv. Men f rst n r disse symptomer har indvirkning p  patientens helbredstilstand og sociale evner, kan vi tale om en psykisk sygdom. Dette indikerer selvf lgelig ogs , at overgangen fra normalitet til sygdom er glidende, og derfor kan defineringen af dette ofte forekomme som en v evende gr ense. Mest interessant i denne case er defineringen af patientens eksistentielle lidelse; i denne lidelsesform m  vi se p  mennesket og hvorledes, det udspiller sig i og forholder sig til verden. I dette finder vi, at lungecancerpatienten sandsynligvis lider af  n angst for d den. Angst kan vi kategorisere som et grundvilk r for mennesket – og angst bliver s rlig evident i forhold til d den, da dette er den absolutte negligerings af menneskeligg ren. Og netop det faktum, at patienten ikke vil erkende, at hendes tilstedev ren er ved at svinde hen, g r, at patienten forn gter sygdomsm essige omst ndigheder, hvilket resulterer i en tilstand af eksistentiel lidelse. Derfor bliver det at fremme patientens selvbestemmelse ogs  til det middel, som skal bidrage til at forbedre patientens eksistentielle tilstand; for kan selvbestemmelsen fremmes via Voksen-ung-modellen, s  kan patienten ogs  gradvist f  en forst else af sin sygdom efterfulgt af en

koh rent pr ference, som kan begrunde, hvorfor patienten eksempelvis kan se det gavnligt at g re brug af det palliative team. Derved kan den fysiske smerte til dels reduceres, men m ske endnu vigtigere p  dette stadie kan den eksistentielle lidelse reduceres, og patienten kan f  sk rpet sin angst og frygt for d den, begrunde sine valg via professionel information, og m ske vigtigst; fremme magten over egen tilv relse.

Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme

Casen med lungecancerpatienten viser, at patienten hverken besidder autonomi i sn ever forstand og ej heller besidder det brede selvbestemmelsesbegreb, personlig autonomi. Efterf lgende har vi set, hvorledes vi kan g re brug af at fremme patientens selvbestemmelse s ledes, at vedkommende er i stand til besidde magt over egen tilv relse med mere. Men hvad skal den professionelle sygeplejerske g re med en patient, som fuldt ud lever op til det reflektive autonomi begreb, som Ekstrom opstiller, samt besidder evnen til at have magt over egen tilv relse, men alligevel v lger ikke at modtage den behandling, og dertilh rende pleje, som de professionelle anbefaler? Lad os se n rmere p  s dan et tilf lde;

"Da Sigmund Freud l  for d den, havde han frygtelige smerter og fik tilbudt morfin. Imidlertid satte han v rdien af et klart hoved h jere end v rdien af smertefrihed og takkede nej³⁶."

Denne korte beskrivelse af psykoanalytikeren Sigmund Freuds sidste tid virker umiddelbart ikke som et tilf lde med konfliktinteresse; ved Kant har vi set, at en autonom person aldrig m  kr nkes, da dette kontradikterer med ytringen om mennesket som m l-i-sig-selv. I dette tilf lde st r dette dog i konflikt til den tidligere belyste paragraf i De Sygeplejeetiske Retningslinjer, hvori der st r, at *sygeplejersken skal medvirke til at lindre lidelse og bist  en v rdig d d* samtidig med, at sygeplejersken skal respektere patientens ret til selvbestemmelse. Dertil har vi nu identificeret de etiske principper, som lader sig v re i konflikt. Ydermere m  vi sp rge, hvem de ber rte parter er; hertil er Freud selv, i

³⁶ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 135

skikkelse af en lidende patient samt, m  vi antage, en sygeplejerske. Sp rgsm let er nu, hvilke muligheder sygeplejersken har i behandlingen og plejen af Freud; skal hun v lge at bruge paternalistisk tvang, hvorved Freud underl gges press n, s ledes at han modvilligt indtager morfin og derved lindres hans (fysiske) lidelse? Eller skal sygeplejersken respektere Freuds autonomi samt ret til selvbestemmelse? Dertil m  vi sp rge; kan vi antage at Freud er autonom samt i stand til at yde selvbestemmelse, n r han tr ffer dette valg? I mods tning til lungecancerpatienten begrundes Freud netop sit valg, og derved bliver hans grundlag klart; valget skyldes et  nske om at have *et klart hoved*. S ledes lader det til, at Freud er velovervejende; han lever op til autonomiens minimumskriterier og er i stand til at yde selvansvarlighed, hvorved han danner sig et m l og s tter en handleplan derefter – i dette tilf lde er det m let om *et klart hoved*. I forl ngelse af dette er Freud s ledes ogs  i stand til at ud ve selvstyre, da han er bevidst om sit  nskede m l og v rdien deraf. I forl ngelse af dette ud ver Freud s ledes ogs  selvudvikling, da han gennem en proces, evaluerer egne v rdier, hvorved han n r frem til afklaring af sine m l og v rdier, og han v lger s ledes dette som en del af det liv, han  nsker at leve. Han retf rdigg r og begrundes sit valg; et valg hvis fundament er et koh rent pr ference system, hvori Freud selv er i stand til at vurdere, hvad der er de bedste konsekvenser for hans valg, og derved hvad der er hans egen individuelle definition af et  nsket gode. Sygeplejersken, som  nsker at modstride sig Freuds  nske, g r s ledes imod tanken om det enkeltes menneskes ret til at leve og udfolde sit eget liv. T nk eksempelvis p  John Stuart Mills ytring om at ens eget liv og evnen til at leve dette er den bedste; *”Hvis en person besidder s  meget som blot en n vnev rdig sum af sund fornuft og livserf ring, er hans egen m de at indrette sig i livet p  den bedste – ikke fordi den er bedst isoleret betragtet, men fordi den er hans egen”*³⁷. Derved kan vi ikke retf rdigg re brugen af paternalisme i dette tilf lde, da Freud besidder personlig autonomi og tr ffer sit valg, p  hvad vi m  antage, velinformerede principper og har forst else for disse.

Sygeplejersken m  respektere Freuds valg, da dette valg er begrundet samt at han er klar over konsekvenserne. Derved kan sygeplejersken ikke retf rdigg re press n og m 

³⁷ Mill, John Stuart; *Om Friheden*. Side 90

derfor acceptere, at Freud v lger et valg, som ud fra et professionelt synspunkt, m ske kan anses for at v re forkert, eller i hvert fald mindre godt. I dette er der tale om et frihedsprincip, som man ikke retf rdigt kan bryde, hverken ved pligt eller konsekvensbetragtende etik. Den konsekvensbetragtende sygeplejerske vil m ske fors ge sig at g re brug af et argument, som lyder p , at Freud ikke er selvbestemmende, og derved m  vi fors ge at fremme hans selvbestemmelse. Men som vist er dette ikke tilf ldet, da Freud fuldt ud lever op til autonomiens minimumskriterier, Ekstroms koh rensteori samt, og i forl ngelse af dette, personlig autonomi. Der er ved dette tale om en patient, som har fuldt ud magt over egen selvbestemmelse, er klar over konsekvenserne af sit valg, hvilket han vurderer skal v gtes som en v rdi af h jere karakter end v rdien af at lindre lidelse.

Sp rgsm let er dog, hvorvidt der n dvendigvis m  tilf jes endnu et kriterium i forholdet mellem autonomi og etik i sygeplejen? Dertil m  vi bev ge os hen mod begrebet omsorg, og hvorledes dette skal ydes i sygeplejen, og om dette begreb kan give os et bredere og mere fyldestg rende perspektiv p  behandlingen og plejen, samt forst elsen, af den ber rte patient.

Om forholdet mellem autonomi og omsorg

Lad os vende tilbage til lungecancerpatienten som ikke lader til at v re samarbejdsvillig med det professionelle personale. Vi konkluderede tidligere, at patienten ikke var i stand til at tr ffe et autonomt valg, fordi hun umiddelbart ikke levede op til Beauchamps minimumskriterium for autonomi. Sp rgsm let er; hvorledes skal man behandle og pleje s dan en patient? Skal man p f re vedkommende paternalisme og i s  fald, i hvilken grad skal den ud ves? Pligtetikken lader ikke til at svare p  dette sp rgsm l og for at finde et svar, m  vi bev ge os v k fra pligtetikken absolutte sf re samt den individuelle konsekvensbetragtende etik og anerkende, at andre perspektiver er n dvendige for at pleje patienten med omhu og omsorg. Begrebet sygepleje betyder, at vi rent essentielt har at g re med en praksis, hvori en patient plejes. Det centrale fundament i dette er *pleje*,

hvilket etymologisk betyder *at b re omsorg for*³⁸. At b re omsorg betyder i sygepleje institutionel praksis, at man har et ansvar over for den anden, alts  patienten. Det centrale er s ledes at se og opfatte patienten som et menneske og ikke blot en pligt. Den konsekvensbetragtende teori pr senteret ved Ekstrom gav os mulighed for at betragte patienten som et individ med et bredere autonomibegreb i form af selvbestemmelse. I forl ngelse af det findes et ontologisk perspektiv, som n dvendigvis m  inddrages i patient forholdet. Et perspektiv som hverken kantianeren eller den konsekvensbetragtende etikker kan redeg re for.

Lungecancerpatienten er ikke kun en patient, men ogs  et menneske – et menneske der m  vises omsorg for, s ledes at hun kan f  den bedste mulige pleje. Knud Ejler L gstrup skrev i sit v rk *Den etiske fordring* fra 1956 at; "*Den enkelte har aldrig med et andet menneske at g re uden at han holder noget af dets liv i sin h nd*"³⁹. "I dette er det den mellemmenneskelige anvisning, som er afg rende; fordringens tavshed medf rer, at det er op til den enkelte selv at finde ud af, hvad der er godt for den anden. Sygeplejersken m  i tilf eldet med lungecancerpatienten fors ge at etablere en livsudfoldelse af den andens tilstedev ren. Dette vil grundl ggende sige, at sygeplejeren m  tage ansvar for patienten og ikke fra patienten. Eksempelvis skal sygeplejersken ogs  inddrage de psykologiske forhold, som spiller ind i forhold til lungecancerpatienten, hendes datter samt valg. S ledes bliver det etiske forhold udvidet; ved pligtetikken var der kun tale om forholdet mellem patienten og de professionelle, men i og med, at *den enkelte har aldrig med et andet menneske at g re uden at han holder noget af dets liv i sin h nd*, s  m  ogs  datteren identificeres i dilemmaet. Der er s ledes konflikt mellem patientens autonomi og personalets professionelle evne til at vurdere, hvad der er bedst for denne samt det faktum, at moderen ikke vil sige farvel til sine p r rende. Efter patientens d d vil der muligvis opst  en situation, hvori de p r rende ikke f ler, at de fik afsluttet sygdomsforl bet p  en v rdig m de, da de ikke fik sagt farvel til patienten. S ledes er det ikke kun datteren, men ogs  de  vrige familiemedlemmer, kollegaer, venner osv. som til en hvis grad m  inddrages i forl bet. Ganske vidst ved den professionelle sygeplejerske bedst – umiddelbart – men de personer, som er inddraget i dilemmaet g r, at ogs 

³⁸ Birkler, Jakob; *Filosofi & sygepleje – Etik og menneskesyn i faglig praksis*. Side 20

³⁹ L gstrup, Knud Ejler; *Den etiske fordring*. Side 25

v rdier er inddraget; derfor er det vigtigt for sygeplejersken at rumme situationen og gribe ind p  det rigtige tidspunkt. P  den anden side skal det involverede personale v re opm rksom p , at patienten har ret til at frasige sig informationen. Dog kan man ved brug af autonomiens minimumskriterium samt Vokens-ung-modellen argumentere for, hvorvidt dette overhovedet giver mening, hvis patienten ikke er autonom. Sygeplejersken balancerer s ledes mellem at have ansvar og p tage sig ansvar; den professionelle st r til ansvar for at udf re sin profession bedst muligt samtidig med, at hun m  p tage sig ansvar for patienten; *"Ansvaret for den anden kan aldrig best  i at overtage hans eget ansvar"*⁴⁰. "Men netop fordi patienten ikke fuldt ud er i stand til at tage ansvar, m  sygeplejersken hj lpe patienten med at udf re sit eget ansvar. Man kan forestille sig, at dialog med lungecancerpatienten vil medf re, at hun kan v re i stand til bedre at indse og forst  sin situation. Dette inkluderer inddragelse af patientens pr ference system og livsanskuelser - og ved at hj lpe til med at patienten er i stand til at yde selvbestemmelse kan man medvirke til, via omsorg, at patienten modtager bedst mulig behandling. S ledes lever sygeplejersken op til, at denne rent faktisk har et ansvar og ikke blot p tager sig et ansvar, da hun via sit ansvar tager patienten metaforisk i h nden og fors ger at hj lpe hende p  rette kurs ved hj lp af omsorg og ikke af pligt. Derved udvikles udviklingen af patientens selvbestemmelse i form af Voksen-ung-modellen samtidig med, at der nu bliver sat konkret handlen p  forholdet mellem sygeplejersken og patienten; at ud ve, i praksis, konsekvensbetragtede etik, som dog g r skridtet videre og vurderer, at grundlaget for ud velsen er omsorg og ikke udelukkende det faktum, at patientens selvbestemmelses evne skal udvikles i  n bestemt retning. Nu bliver flere perspektiver mulige. Ikke kun i teori men ogs  i praksis. Dertil kr ver det, at sygeplejersken selv lever op til og udvikler et ideal, som hun skal leve op til for at bevare sin egen v rdighed og integritet i henhold til hendes profession.

I det f lgende vil vi se, hvorledes L gstrups etik danner et grundlag for den sygeplejeetiske ideal etik.

Grundl ggende kan vi sige, at L gstrups etik kan v re med til at forst  samt give et handlingsgrundlag for de eventuelle etiske dilemmaer, sygeplejersken ofte befinder sig i.

⁴⁰ L gstrup, Knud Ejler; *Den etiske fordring*. Side 39

Dog skal L gstrups ontologiske etik i denne kontekst ikke l ses adskilt fra Kants pligtetik, da den kantianske tese om fornuftsv snets absolutte v rdi er den grundl ggende i henhold til respekten for patientens autonomi. Dog afviger L gstrup fra Kants etik p  et omr de; fornuftsv snet, alts  menneskets, uafh ngighed.

Der m , if lge L gstrup, inddrages et dualistisk forhold, interdependens, mellem de implicerede parter; vi kan ikke se p  mennesket, autonomt eller ej, som en isoleret, selvskabende, genstand, hvilket Kant giver udtryk for i sin etik. Af samme grund kan pligtetikken ikke st  alene i den sygeplejeetiske kontekst, da s dan ideologisk og endimensionel livsforst else kan f re til st rk paternalisme;

‐Den [livsforst else] kan stivne til en ideologi og for den enkelte blive en simpelthen absolut st rrelse. Jo mere det sker, desto mere bliver den enkelte forholdet til andre mennesker en anledning til anmasselse og eventuel overgreb⁴¹.‐

S ledes m  patientens livsforst else inddrages i behandlingen, da andet vil v re en bedrevenhed, hvori man kan tiltvinge patienten u nsket anmasselse, hvorved man eksempelvis, indirekte, presser patienten til at foretage et valg, som vedkommende ikke  nsker. Derved m  sygeplejersken anerkende, at i m det med patienten opst r etikken, og derfor kan den professionelle ikke blot p tvinge patienten egne principper og regler. Konsekvensen af dette er, at sygeplejersken, i den etiske konflikt, kan genkende tidligere forhold i situationen; det vil sige at have et grundlag for at overf re tidligere erfaringer fra lignende situationer til den specifikke situation⁴². I konflikten med lungecancerpatienten og hendes datter m  sygeplejersken vurdere de ontologiske grundvilk r, som finder sted i situationen – vedkommende m  forestille sig selv i patientens sted og tr ffe sit valg begrundet i professionelt samt medmenneskelig henseende og (med)forst else; fordi b de patienten og den professionelle p  menneskeligplan er afh ngige af hinanden. I sin belysning af dette i v rket *L gstrup og Sygeplejen* udtrykker Kari Martinsen forholdet s ledes; *‐Vi kommer hinanden ved, og det er ikke noget, vi v lger, og ikke noget, vi kan argumentere for. Selv n r vi er mest suver ne og selvst ndighed, er vores styrke og*

⁴¹ L gstrup, Knud Ejler; *Den etiske fordring*. Side 35

⁴² Martinsen, Kari; *L gstrup & Sygeplejen*. Side 51

*uafh ngighed fundamentalt set en afh ngighed af andre*⁴³.” Patienten m  anses som et menneske med v rdighed og integritet, som ikke kan kr nkes; vedkommende er afh ngig af sygeplejersken, l gen osv. p  samme m de, som de er, i  n eller anden grad, er afh ngige af patienten. Den professionelle kan ikke blot foretage et rent naturvidenskabeligt valg p  vegne af patienten, da s danne valg ikke inddrager de ontologiske perspektiver, hvori blandt andet omsorg findes. Og da den professionelle og patienten *kommer hinanden ved*, kan man ikke undlade at inddrage de medmenneskelige perspektiver i behandlingen og plejen af patienten.

De medmenneskelige perspektiver kommer til udtryk, if lge L gstrup, ved de suver ne livsytringer; udgangspunktet er, at etikken kommer til udtryk i f retiske suver ne livsytringer; tillid, barmhjertighed, medf lelse mm⁴⁴. Derved kan vi tale om noget, som er bestemt p  forh nd. Det vil sige; de suver ne og spontane livsytringer er bestemt, f r vi har bestemt dem; *”I fordringens ensidighed kommer det til udtryk, at vi modtager livet i tillid til det at pr give os til det*⁴⁵.” Dette betyder, at vi st r til ansvar for vores handlinger, fordi livet er os sk nket – heri tanken om fordringens ensidighed. L gstrups etik er, p  trods af tanken om livets sk nkethed og ensidighed,  ben for selvudfoldelse og ansvar; etikken er spontan. Den forefindes i situationen via de suver ne livsytringer. Dette er i klar kontrast til Kants etik, hvori etikken allerede p  forh nd er forudbestemt af universalgyldige principper. Etikens spontanitet er begrundet i en spontan godhed; etikken vokser frem i situationen, da der allerede p  forh nd er noget betydnings- og v rdifuldt p  spil; noget som vi ikke selv er med til at skabe og forme. Etikken er ikke blot en standard, som vi skal fors ge at leve op til, men vi m  tage den i vores h nd og s  vidt muligt fors ge at leve op til vores etiske ansvar; at vi altid har at g re med det andet menneske, og at vi skylder det bedste grundet livets sk nkethed. Det vil sige, at fra tilliden og kendsgerningen udspringer fordringen om, at vi som mennesker skal tage vare for hinandens liv. I sygeplejen kommer dette til udtryk ved eksempelvis tillid. Sygeplejersken vil altid st  over for kendsgerningens interdependens. Den tavse fordring er uudtalt, og sygeplejersken skal v re i stand til at tr ffe et valg begrundet i omsorg

⁴³ Martinsen, Kari; *L gstrup & Sygeplejen*. Side 52

⁴⁴ Martinsen, Kari; *L gstrup & Sygeplejen*. Side 52

⁴⁵ L gstrup, Knud Ejler; *Den Etiske Fordring* Side 136

samt professionalisme. Der m  s ledes inddrages en subjektivt livsforst else, som er grundlagt gennem sygeplejerskens tidligere erfaringer samt en naturlig forst else af, hvad der er det bedste for patienten. Sygeplejersken og patienten er forbundet med hinanden, og i omsorgen findes den f retiske suver ne livsytring *tillid*; en sygeplejerske og patient, som ikke besidder et interdependens tillidsforhold, vil ikke v re i stand til at aktualisere det faktum, at de til en vis grad er forbundet med hinanden i situationen, og derved bliver omsorgsbegrebet reduceret til ikke-v rende i og med, at den professionelle og patienten ikke m der og anerkender hinanden i et tillidsforhold men et mistillidsforhold. Det vil ikke v re muligt at leve op til fordringens radikalitet, hvori den enkelte skal fors ge at tage den andens liv i sin h nd og ville vedkommende det bedste. Dette kan ikke v re muligt, hvis et mistillidsforhold er det grundl ggende frem for et tillidsforhold; *"Uanset hvor stort eller ringe udvortes set det er, der skal g res, er fordringen radikal, fordi den enkelte if lge sagens natur ikke af nogen anden, men kun af sin egen uselviskhed kan f  at vide, hvad der tjener den anden bedst"*⁴⁶. "Dette skyldes, i min optik, at i mistillidsforholdet kommer eget subjekt f r det andet subjekt; man begrunder sine valg og handlinger i en egocentrisk tendens, hvori den anden tilsides ttes for egeninteresse, hvilket betyder, at man ikke kan v re i stand til at opfylde de suver ne livsytringers krav, fordi der s ledes ikke kan v re tale om en spontanitet. Ej heller kan s danne suver ne livsytringer v re anonyme. F lger sygeplejersken til geng ld L gstrups tanke om livsytringen, bliver hun i stand til at handle i og med, at der i situationen forlanges noget af sygeplejersken; nemlig omsorg.  n omsorg som ikke kan komme til udtryk, hvis sygeplejersken og patientens forhold er baseret p  mistillid. Tilliden er s ledes det, som giver sygeplejersken grund til at handle. Men modsat den kantianske etik, hvori der allerede p  forh nd er tale om absolut princip, hvori den enkelte n dvendigvis skal f lge pligten for at handle af moralskv rdifuld karakter, kan vi ved L gstrup forlange mere end d t; at sygeplejersken viser omsorg grundet fordringen. Og p  trods af, at den ensidige fordring er skabt, henleder den til, at sygeplejersken m  ud ve en handling i erkendelse af, hvad vedkommende skylder det andet menneske, alts  patienten. Kari Martinsen udtrykker dette forhold s ledes; *"Jeg svinger noget vigtigt i mig selv, n r jeg svinger mit ansvar for den andens ve og vel"*⁴⁷. "Den

⁴⁶ L gstrup, Knud Ejler; *Den Etiske Fordring* Side 56⁴⁷ Martinsen, Kari; *L gstrup & Sygeplejen*. Side 55

professionelle m  n dvendigvis leve op til sit ansvar – et etisk ansvar som b de inkluderer patienten samt sygeplejersken selv.

Problematikken ved de spontane livsytringer er dog det faktum, at vi ikke altid handler spontant; vi kan ikke altid spontant vise den anden umiddelbare tillid og barmhjertighed. Dette betyder, at for at leve op til fordringens ensidighed, kan vi s  vidt muligt fors ge at efterleve den⁴⁸. Bliver vi selviske i vore handlinger, m der vi den anden med mistillid f r tillid, s  fejler vi i vore livsforst else, fordi vi ikke erkender den kendsgerning, at livet er os sk nket, og vi kan ikke blot forlange fordringen p f rt vore egeninteresse via den anden, da dette er en oph velse af fordringens ensidighed. At vi ikke altid er i stand til at handle spontant efter livsytringerne betyder, at vi har brug for en vejledende regel, s ledes at vi er i stand til at erkende, hvorledes vi skal handle. Det vil sige, at vi har behov for en regel som kommer efter spontaniteten;

‐Fordringen er blandt andet formuleret i den gyldne regel: Alt hvad du vil at de andre skal g re mod dig, skal du g re imod dem. Den er alt andet end en lunken regel om at g re geng ld. [...] Den er tv rtimod en regel for brugen af vor fantasi. Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi vil  nske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted – for s  aktuelt at handle imod den anden p  den m de⁴⁹.‑

I sygeplejeetisk henseende betyder dette, at den professionelle m  bruge sin fantasi til at s tte sig i patientens situation. Eksempelvis, at sygeplejersken kan forst  den f rn vnte patient med lungecancer og hendes datter p  s danne m de, at hun f r langt st rre og mere eksistentiel indblik i lungecancerpatientens situation, end hvis sygeplejersken n gternt ville v lge kun at inddrage den kantianske pligtetik, hvori hun rent professionelt kan give en vurdering af, hvorvidt patienten er autonom, og hvilken beslutning vil v re bedst for patienten, men ikke vil v re i stand til at give en vurdering af patientens eksistentielle eksistens og v rdighed. For nok kan Beauchamp give et grundlag for, hvorvidt patienten er autonom eller ej, men han vil ikke v re i stand til at vise lungecancerpatienten omsorg, da han ikke kan g re brug af det redskab, som

⁴⁸ Det skal dog tages i betragtning at fordringen er uopfyldig og at vi derved aldrig vil kunne opfylde denne if lge L gstrup.

⁴⁹ Martinsen, Kari; freml ggelse af L gstrups formulering af den gyldne regel som er formuleret i Matth usevangeliet 7,12: L gstrup & Sygeplejen. Side 55

L gstrup pr senterer i sin filosofi; at t nke sig selv ind i den andens situation samt eksistentielle ve og vel. Bruger vi L gstrup til dette, bliver sygeplejersken netop opm rksom p  sit ansvarsomr de p  s danne m de, at vi kan t nke hende ind i et ideal karakter, hvori patienten, alts  den anden, bliver vendt mod sygeplejersken (jeget) og derved forenes disse to p  et holistisk eksistentielt niveau, som ikke kommer til udtryk i kantianismen. Derved kan sygeplejersken handle ud fra idealer, som tilbyder, at sygeplejersken er i stand til at handle med omsorg, hvilket betyder, at hun kan tage ansvar for sine valg med etisk ansvarlighed samt integritet⁵⁰. Men i og med at der i dette er tale om karakter-ideal, m  sygeplejersken, ved hj lp af sin erfaring, fantasi og indsigt, selv drage egen konklusion om, hvilken form for omsorg, der skal vises og ud ves for eksempelvis lungecancerpatienten og hendes datter. I henhold til L gstrup er fantasien i stand til at skabe rum for sygeplejerskens sk nm essighedstagen i situationen, og det er s ledes fantasien, som skaber rum til disse overvejelser samt begrundelse for sygeplejerskens handling⁵¹.

Sk nm essighedstagen g r, at sygeplejersken kan indleve sig i den ber rte patients tilstand. Ikke kun naturvidenskabeligt, men ogs  ontologisk. Derved bliver idealet for sygeplejersken ikke kun at tage hensyn til patienten, men ogs  at tage hensyn p  s danne m de, at hun ber rer patienten p  eksistentiel vis. Sygeplejerskens rolle bliver at idealisere sine karaktertr k, sine dyder, s ledes, at de er medvirkende til, at b de sygeplejersken selv, samt patienten, fungerer godt som menneske. Det vil sige, at sygeplejeren i situationen skal vurdere situationens middelvej og derved undg  at underdrive situationen samt overdrivelse af situationen. Jeg vil p pege, at for lidt omsorg i situationen betyder, at sygeplejersken udviser ligegyldighed og m ske endda hensynsl shed over for patienten, mens for meget omsorg betyder, at sygeplejersken omklammer patienten p  s danne m de, at patienten ikke er i stand til at tage vare for sig selv. Man kan sige, at selvf lgelig har sygeplejersken en pligt til at sikre patientens bedste, men hun m  ikke binde sig til den rene deontologiske struktur, da sygeplejersken s ledes nok vil have pligt til at udf re sin gerning, men hun vil ikke n dvendigvis v re forpligtet til

⁵⁰ Husted, J rgen; *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Kapitel 4

⁵¹ Martinsen, Kari; *L gstrup & Sygeplejen*. Side 55

at ville det bedste for den enkelte patient. Dette g r, at ved pligtetikken lader det til, at sygeplejersken i situationen ofte kan ende i en situation, eksempelvis ved sp rgsm let om lungecancerpatientens autonomi og valg, hvor hun tager ansvar fra patienten og ikke for patienten. Vurderer pligtetikeren, at den vedr rte patient ikke er autonom, s  gives der ikke noget svar p , hvordan sygeplejersken skal varetage sin forpligtelse over for patienten, da hun ganske vidst lever op til sin pligt, men derved fraskrives ogs  det faktum, at der b r tages ansvar for patientens eget bedste - ikke fra patienten - og til et objektivt bedste. Til geng ld kan vi sige, at L gstrups etik ej heller tilbyder nogen direkte specifik l sning til det etiske dilemma, som den professionelle m der i givende tilf lde. Dog gives der et fingerpeg om, hvor en eventuel l sning findes; ved brug af sk n og vurdering af den specifikke situation skal sygeplejersken vurdere beskaffenheden heraf og derefter tage stilling til, hvad der er bedst for patienten og eventuelt vedkommendes p r rende.

I behandlingen af lungecancerpatienten kan vi i forl ngelse af denne skildring sp rge, hvilken behandling og pleje er bedst for patienten? Den pligtetiske, hvori vi udelukkende forholder os til at respektere patientens autonomi (hvis denne er til stede), undg  skade samt at behandle patienten retf rdigt, alts  som et m l-i-sig-selv som g r, at vi i dette specifikke tilf lde ikke er i stand til at forst  den ber rte patients eksistentielle tilstand – den pligtetiske sygeplejerske er nemlig ikke i stand til at se sig selv i patientens sted, fordi hun n gternt handler ud fra de f rn vnte principper og derved ser sig blind for  vrige behandlings muligheder. Indbefatter sygeplejersken til geng ld idealetik, og ikke n dvendigvis udelukker pligtetikken, eller den konsekvensbetragende etik, kan vi, hvis vi f lger L gstrups ontologiske perspektiv, give et grundlag for, at sygeplejersken kan v rne og ikke mindst fremme patientens bedste, hvori det m ske vigtigste fundament i sygeplejen indg r; et medmenneskeligt ansvar, hvori der er plads til forst else for, og af, patientens situation. Derved lever sygeplejersken op til b de det professionsetiske krav om at *“...erkende og vedkende sig det etiske faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger”*⁵² samt *“...arbejde for at patienten bevarer sin v rdighed og integritet”*⁵³.

⁵² Sygeplejeetisk r d 2010.  1.2

⁵³ Sygeplejeetisk r d 2010.  2.4

Den professionelle erkender det faglige ansvar ved at forst  patientens sygdomsforl b fra et professionelt perspektiv – derved v rnes der om de faglige omst ndigheder. Derudover kan vedkommende v rne om det personlige ansvar, hun har over for den enkelte patient. Dette m  forekomme i professionelt henseende, men i og med, at der g res brug af egne sk n og vurderinger i situationen,  bner sygeplejersken op for et bredere perspektiv, som g r, at sygeplejersken ikke kun sikrer forholdet mellem sygeplejersken og professionen, men ogs  sikrer at leve op til de retningslinjer, som er forskrevet mellem sygeplejersken og patienten. At sikre sammenspillet mellem disse poler er at handle med professionel integritet, hvorved den professionelle anerkender det faglige samt etiske ansvar, vedkommende har over for sygeplejepraksissen. Denne skildring mellem sygeplejeetikken er ikke ny; allerede for cirka 2400  r siden  bnede den gr eske mastodont filosof Platon op for sp rgsm let om en n dvendighed af en idealtilgang funderet i den enkelte karakters professionelle m ls tning og gerning; har vi ikke det n dvendige ideal etiske perspektiv med, kan den professionelle praksis ikke leve op til sit eget ideal. Platon stiller s ledes sp rgsm let; hvilke v rdier skal kendetegne sygeplejen – derved hvilke holdninger og principper den professionelle (sygeplejerske, l ge osv) skal repr sentere⁵⁴. Platon skildrer i det f lgende mellem den frie og den ufrie l ge. I denne analyses optik skal den ufrie l ge anses som repr sentant for en endimensionel etik, hvori der ikke gives plads til omsorg, idealer samt  vrige perspektiver, mens den frie l ge repr senterer den professionelle, som giver plads til et eksistentielt og karakterpr get syn p  patienten og sygdomsforl bet⁵⁵;

‐Den frie l ge derimod behandler i reglen de frie menneskers sygdomme og tager sig af dem, og han unders ger dem fra grunden og systematisk og forhandler med patienten selv og hans venner, og derved lærer han ogs  selv noget af de syge, og desuden lærer han selve patienten noget, s  godt han da kan, og han giver ham ikke nogen ordination, f r han mere eller mindre har f et hans samtykke dertil, og n r han s  ved stadigt at anvende gode ord har f et patienten gjort f jelig, fors ger han at skaffe ham fuldst ndig

⁵⁴ Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 4

⁵⁵ L ser bedes have i notits at denne skildring ikke kun kan anvendes p  l ger men ogs  sygeplejersker mm, hvilket er dette speciales specifikke udgangspunkt.

*helbredelse. Skal vi s  foretr kke, at en l ge anvender den ene eller den anden
helbredelsesmetode?⁵⁶ ”*

I og med den frie l ge, eller sygeplejerske, form r at s tte sig ind i patientens livsforst else og situation, anerkender den professionelle patienten som et individ, som har valgt at v lge sit eget liv. Det vil sige, at patienten anerkendes som det specifikke individ, som det nu engang er – som et m l-i-sig-selv. Dette kan b de den kantianske pligtetik og L gstrups ontologiske etik blive enige om. Lad os antage, at lungecancerpatienten lever op til de f rn vnte opstillede krav for autonomi; *intention, forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse* som blev opstillet af Beauchamp. Grundlaget for dette er det kantianske Kategoriske Imperativ, hvori den enkelte besidder evnen til at bakke op om  n objektiv gyldig moral regel. Hvis patienten ikke lever op til dette, s  kr nker vedkommende sig selv og sin v rdighed. Problemet er, at der derfor ikke bliver plads til et menneskeligt ideal om personlig autonomi, men kun moralsk autonomi. Den ufrie l ge, som anser patienten som  n blandt mange, form r ikke at medtage den enkelte patient, men kun kategorisere patienten som  n blandt mange. Patienten m  og skal altid behandles som m l-i-sig-selv, som pligtetikken fordrer, men dette m  n dvendigvis ogs  betyde, at den enkelte netop ikke kan behandles p  m den, som den ufrie l ge praktiserer. Den frie l ge, og sygeplejerske, form r til geng ld at komme ud over denne problematik ved at anerkende, at patienten, i kraft af sin personlige autonomi, det vil sige selvbestemmelse, form r at tr ffe valg, som begrundes i idealer og livsanskuelser. Derved kan den frie l ge og sygeplejerske behandle og pleje lungecancerpatienten p  s danne m de, at hun ikke kun yder klinisk behandling af patienten, men ogs  form r at vise omsorg, respekt og forst else for patientens situation ved inddragelse af patientens integrerede selv og dertilh rende pr ference system. Det vil sige, at den professionelle ikke kun bekymrer sig om selve det faktum, at patienten har lungecancer, og hvorledes dette specifikt kan behandles, men ogs  det faktum, at hun rent faktisk har nogle livsanskuelser og v rdier, som der m  v rnes om. Derved anses patienten, som sandsynligvis fra et l geligt synspunkt tr ffer et d rligt valg, stadig som autonom, hvis  nsker man n dvendigvis m  respektere, s  l nge at hun er autonom, og derved m  man

⁵⁶ Platon; *Lovene*. Bog IV. Side 141

anerkende hendes valg. S ledes bliver patienten betragtet som et ganske unikt individ, som har skabt sig et liv p  egne v rdier og grundlag – v rdier og grundlag som st r til grunde for patientens beslutning. S ledes kan vi konkludere, at den frie l ge og sygeplejerske kan vise omsorg i og med, at de forst r og anerkender patientens liv i et st rre holistisk sammenh ng⁵⁷.

Kritik af det ontologiske omsorgsideal

Det skal ikke st  til diskussion, at L gstrups etik giver grundlag for, at omsorg er en n dvendighed i sygeplejens etiske univers. Den frie l ge – og sygeplejerske – er i stand til at forst  patienten; ikke kun sygdommens patologiske anatomi, men ogs  den lidelse, som sygdom kan forvolde den ber rte patient og omgangskreds. Men dermed ikke sagt, at omsorg er den grundl ggende faktor i forholdet mellem patienten og den ud vede etik i sygeplejen; jeg vil i det f lgende for argumentere, at det ontologiske omsorgsideals mangler et grundl ggende fundament, som g r, at dette perspektiv ikke kan positioneres p  lige fod med hverken det kantianske autonomibegreb og pligten, som heraf f lger, eller det konsekvensbetragende etiske grundlag, hvori selvbestemmelsens brede autonomibegreb har sit udspring.

Det f rste kritiske sp rgsm l vi kan rette mod det ontologiske omsorgsideal er, hvorledes, hvis vi ‘*blot*’ skal anvende sk nm essighedstagen i situationen, kan vi undg  at handle vilk rligt; det vil sige at handle efter de naturlige tilb jeligheder? M  der ikke n dvendigvis v re en h jere kategorisk instans, som sikrer, at vi netop ikke blot handler efter antagelser men efter en gyldig almen lov, det Kategoriske Imperativ. Problematikken for omsorgsidealet er, at vi, if lge L gstrup, skal bruge fantasien til at s tte os i den andens sted. Men dette betyder ogs , at de valg vi foretager, ikke kan v re moralsk v rdifulde, fordi begrundelsen er foretaget i vores antagelser, meninger, holdninger osv. Begrebsm essigt kan vi s ledes kategorisere dette under det filosofiske begreb *doxa*, hvor sygeplejersken blot antager sin position og holdning for at v re begrundet i en viden om patienten. Dette er dog rent illusion, da positionen mangler det epistemiske indhold, som

⁵⁷ Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 5

g r, at man kan sikre patienten det bedste. Dette indhold finder vi netop ved Kants Kategoriske Imperativ, som er i stand til at beskytte patienten mod paternalistisk formynderi og omsorgsm essig omklamrenhed. Den kritiske ideal og omsorgsetikker vil sandsynligvis s tte sp rgsm lstegn ved, hvorvidt det Kategoriske Imperativ altid skal f lges, da der kan opst  situationer, hvor dette ikke lader til at v re tilstr kkeligt. Hertil m  svaret lyde, at sygeplejersken har et ansvar over for patienten, hvilket ikke st r til diskussion, men lever patienten op til de kriterier, som udg r autonomiens minimumskriterium, s  kan man ikke retf rdigg re, at patientens rettighed kr nkes, da s danne kr nkelse netop vil v re at p f re patienten et u nsket gode, og derved bliver den omklamrende omsorg til et u nsket paternalistisk indgreb – p  trods af at patienten rationelt har argumenteret for, at vedkommende ikke  nsker dette. Derved modstrider s danne sygeplejerske tanken om patientens, og det enkelte menneskes, ret til autonomi, da man ikke anerkender patientens evne til at t nke og handle selv, og derved respekteres fordringen om respekt for autonomien ikke. Den negligeres til geng ld til ikke eksisterende, og patienten bliver reduceret til et middel og ikke et m l.

Ydermere kan vi stille os kritiske i forhold til, hvorvidt det ontologiske omsorgsideal kan sikre patientens ret til informeret samtykke. Hvorledes kan denne etiske position sikre et aftaleforhold, hvor patienten f r de oplysninger, som er n dvendige for at tr ffe et velinformeret valg? Antager man blot, hvad der er bedst for patienten ved at forestille sig at v re i patientens sted, som vi m , som belyst tidligere, *fantasere os til, hvordan vi vil  nske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted*, men kritikken her af skal lyde, at dette ikke er nok til at retf rdigg re antagelsen af, at patienten har modtaget de informationer, vedkommende skal bruge samt at patientens valg respekteres. Derimod kan den konsekvensbetragende etik sikre patienten samtykke p  et velbegrundet grundlag, da etikken, som tidligere vist, opstiller krav til patienten samt sygeplejersken. Patienten skal tr ffe refleksive valg begrundet gennem kritisk evaluering, af hvad vedkommendes individuelle forst else af det gode er, og dette skal n dvendigvis stemme overens med patientens valg af pr ferencer. Ved hj lp af dette kan patienten ud ve en acceptable sum af selvbestemmelse, s ledes at valget m  respekteres. Dette sker i kraft af, at patienten har forst else for sin situation og har overvejet og kan begrunde, sine

valg. I forl ngelse af dette skal sygeplejersken s rge for, at patienten modtager den korrekte information, s ledes at patientens valg træffes p  et sikkert grundlag. Patienten beskyttes s ledes ved indhentet informeret samtykke i kraft af sin egen evne til at forst  situationen og sine pr ferencer samt sygeplejerskens professionelle videregivelse af information. Derved sikres patientens selvbestemmelsesret samt retten til frasigelse p  et sikkert teoretisk grundlag. Dette grundlag adskiller sig markant fra det ontologiske perspektiv, hvori vi ikke kan vide os sikre p  patientens  nske, men blot antage, hvad der er bedst for vedkommende.

Kritikken af det ontologiske ideal og omsorg skal dog ikke forstås som en udelukkelse af anvendelse af omsorg i sygeplejen. Tv rtimod. Men den skal sikre, at sygeplejersken ikke formynder paternalisme eller omklamrende omsorg over for patienten og derved tilsides tter patientens rettigheder, behov osv. for en bedrevidenhed af, hvad der ville v re bedst for patienten. Derudover sikre den kantianske etik at det enkelte menneske altid behandles med v rdighed og som m l-i-sig-selv. Dette er n dvendigt for at institutioner og praksisser i dagligdagen ikke lader normer blive til v rdi. For bliver doxa-normer, det vil sige, normer som man antager for at v re korrekte uden sikkert grundlag, hverdagspraksis, s  kan de principper, som henholdsvis pligtetikken og den konsekvensbetragende etik sikre, blive nedgraderet i forhold til det ontologiske omsorgs perspektiv i den hierarkiske struktur. I tilf lde af s danne hierarkisk strukturdegradering kan vi forestille os en praksis, hvorved eksempelvis omklamrende behandling af patienten bliver dagligdag, og derved vil behandlingen og plejen af patienten blive sk mmet af misologi, hvorved kun den blotte antagelse af, hvad der er korrekt for patienten, og ikke den begrundede, vil blive det f rende princip, hvorp  sygeplejersken foretager sine valg. Og foretages behandlingen og plejen af patienten uden nogen fornuftm essig indsigt, s  kr nker dette, ubetinget, b de patienten og sygeplejersken. Patienten kr nkes, da vedkommende ikke gives plads til at udfolde sine egne  nsker og behov – i kraft af at autonomien og selvbestemmelsen ikke inddrages i en omklamrende omsorgs pleje – og sygeplejersken kr nker sig selv, fordi hun ikke lever op til sin professionelle professions krav.

De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis

Vi har p  nuv rende tidspunkt analyseret og diskuteret tre etiske positioner, som giver den professionelle sygeplejerske mulighed for at begrunde sine valg og handlinger i henhold til vurderingen af, hvorvidt en patient er autonom eller ej, samt hvorvidt den autonomes valg altid skal respekteres, eller om der kan forekomme tilf ælde, hvor dette princip m  underkendes. Sygeplejerskens profession g r, at hun i sin dagligdag ofte m der etiske sp rgsm l, som kommer til udtryk ved m det mellem patienter, kollegaer, institutionspraksis osv. Netop derfor er det ogs  n dvendigt for sygeplejersken at vurdere sine etiske valg og handlinger, fordi disse valg ofte vil v re i konflikt med de  vrige ber rtes vurderinger og eventuelle handlinger. Principperne, som analysen har anvendt, er brugbare til dette, da de giver sygeplejersken et grundlag for at argumentere for sine etiske vurderinger. Det vil sige, at der er en klar r d tr d mellem sygeplejerskens praksisstandarder, som er at forefinde ved de Sygeplejeetiske Retningslinjer og de principper, som st r til grundlag for disse. Principperne er grundl ggende f stnet i de m l og v rdier, som identificerer sygeplejerskens ansvarsomr de. Disse omhandler; *”Det enkelte menneskes v rdighed, v rdien af medmenneskeligt ansvar og omsorg samt v rdien af professionel integritet”*⁵⁸. Dette er s ledes de grundl ggende professionelle v rdier i sygeplejen, men for at ud ve dem, m  sygeplejersken f lge de principper, som g r dette muligt.

Det, som vi skal v re opm rksomme p , er, at principperne kan, i visse situationer, v re modstridende og konfliktfulde; eksempelvis kan det pligtetiske princip om at respektere autonomi v re i et konfliktforhold med det konsekvensbetragende princip om at lindre lidelse. Derudover kan principper indbyrdes obstruere for hinanden. Eksempelvis kan det konsekvensbetragende princip om at forebygge negativ sundhed v re i konflikt med princippet om at lindre lidelse. Dette betyder, at den Professionsetiske Beslutningsmodel, som vi har anvendt analysen igennem, ikke kan anvendes som en facitliste, hvori det ubetingede korrekte svar altid vil v re at finde. Beslutningsmodellen er et redskab til at man vrere gennem de etiske konflikter, som sygeplejersken m der i sit

⁵⁸ Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 9

professionelle erhverv. Med denne beslutningsmodel bliver den professionelle i stand til at argumentere for sin etiske beslutningstagen, og position og derved kan sygeplejersken retf rdigvis leve op til den grundl ggende v rdi af professionel integritet, hvorved den professionelle tager ansvar for sin handling.

Analysen igennem har vi taget udgangspunkt i det filosofiske begreb autonomi, og hvorledes den professionelle sygeplejerske skal v re i stand til at vurdere og forholde sig til, hvorvidt en patient er autonom, og hvorledes hun kan pleje og behandle patienten med v rdighed og integritet. Vi har bev get os fra filosofisk teori til en praksisorienteret anvendelse af autonomi og etik i sygeplejen. I dette findes dog to problematikker; sp rgsm let om pleje omhandler ikke altid, m ske n rmest langt fra, sp rgsm let om, hvorvidt en patient er autonom eller ej og dern st, at sygeplejersken i sit erhverv ikke har tidsm essige ressourcer til at bearbejde patientens sygdomsforl b og forhold p  et rent filosofiteoretisk grundlag. For at l se disse problematikker m  sygeplejersken vurdere, hvilken v rdi hun v gter h jest i den konkrete situation; at Freud v lger ikke at ville modtage morfin, er et eksempel p  dette. Den professionelle vurderer, at den korrekte behandling og pleje af Freud er ikke at lindre hans lidelse men at sikre, at han er i stand til at t nke klart p  trods af ulidelige smerter. Det vil sige, at v rdien af respekt for autonomi vurderes til at v re af h jere karakter end princippet om at lindre lidelse. I teori har vi anvendt Kant og Ekstrom til at komme frem til dette resultat. Men sygeplejersken har ikke disse muligheder, men skal stadig v re i stand til at redeg re for sine etiske valg. Dertil kan den professionelle anvende Den Professionsetiske Beslutningsmodel, hvori den professionelle kan bev ge sig fra et etisk dilemma til det konkrete valg samt handling. Hertil opstilles f lgende punkter som fokuserer p  handlinger der;

- *Respektere klientens autonomi*
- *Ikke volder skader, modvirker eller hindrer skade*
- *Fremmer klientens bedste interesse*
- *Behandler klienten retf rdigt og fremmer bestemte fordelinger*
- *Overholder love, professionsetik mv.⁵⁹*

⁵⁹ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 212

Disse punkter skal altid medt nkes, n r man skal fors ge at l se et etisk dilemma i henhold til etik i sygeplejen. Indledningsvis skal dilemmaet pr ciseres; i dette skal sygeplejersken identificere de etiske principper, som er relevante for den etiske konflikt. Indl ser vi den Professionsetiske Beslutningsmodel i dette, betyder det, at vi skal identificere de konkrete formuleringer af relevante principper. Eksempelvis en konflikt mellem Respekt for autonomi og princippet om at lindre lidelse. Efterf lgende skal ogs  de ber rte parter noteres; familie, venner, institutionen mm – det vil sige de parter, som ber res af det etiske valg. I forl ngelse af dette m  den professionelle ogs  v re i stand til at vurdere de realistiske valgmuligheder.

Analysen og diskussionen igennem har vi understreget n dvendigheden af at begrunde valg og handlinger; dette skyldes, at vi skal v re i stand til at prioritere v rdier p  et rationelt grundlag og v re i stand til at skelne v rdierne fra hinanden. Man m  i behandlingen og plejen opstille et hierarkisk system, hvori man vurderer, hvilken v rdi er af h jeste karakter og hvilke er mindre n dvendige i denne specifikke behandling. Er der stadig tvivl, om hvilke v rdier som er af h jeste karakter, m  en dybere etisk analyse p begyndes. I denne etiske analyse skal den professionelle identificere valgmuligheder og give etiske grunde for at v lge mulighed-X frem for mulighed-Y⁶⁰. N ste skridt er afvejning, hvori grundene, b de for og imod, alle tages i betragtning for derefter at v lge det valg, som er mest forsvarligt. Endelig skal sygeplejersken r df re sig med andre; det vil sige at freml gge sine vurderinger for andre, s ledes at hun eventuelt kan f  r d og vejledning af andre professionelle. Efterf lgende foretages det endelige valg; hvori sygeplejersken, i s  fald denne procedure er fulgt, gerne skulle v re i stand til at tr ffe et etisk korrekt og v rdifuldt valg.

De Sygeplejeetiske Retningslinjers grundlag er at s tte v rdien af det enkelte menneske i centrum – dog uden at forglemme, at dette unikke menneske lever i sammenh ng med sine omgivelser. Der er s ledes tale om tillid til og respekt for det enkelte menneskes valg og  nsker. Og det er i denne sammenh ng at retningslinjerne bist r som en assistance til, at sygeplejersken kan udvikle og ud ve sygepleje mod et menneske, som netop har behov for s danne pleje. Ved hj lp af retningslinjerne

⁶⁰ Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. Side 190

medvirkes der til, at etiske diskussioner samt overvejelser belyses. Dertil er retningslinjerne i stand til at begrunde sygeplejerskens etiske valg samt i forl ngelse af dette bidrage til fremme af sygeplejerskens d mmekraft i situationen, hvorved den faglige professionalisme udvikles⁶¹. De Sygeplejeetiske Retningslinjer er ikke kun omhandlende forholdet mellem sygeplejersken og patienten, men ogs  mellem sygeplejersken og professionen samt sygeplejersken og samfundet. Dog understreges det, at De Sygeplejeetiske Retningslinjer ikke er prioriteret i noget hierarkisk v rdisystem; dette betyder, at vi ikke kategorisk kan konkludere, at en paragraf i retningslinjerne er mere v rd end  n anden. For at vurdere, hvilken der er af h jst v rdi i det enkelte etiske dilemma, kr ver det en mere uddybende begrundelse af sygeplejersken.

Afslutningsvis kan vi konkludere, at sygeplejerskens ansvarsomr de grundl ggende best r af fire facetter; *fremme sundhed, forebygge sygdom, genoprette sundhed og lindre lidelse*. Derudover s tter sygeplejerskens praksis hende i forhold til; *profession, patienten, medarbejder og samfundet* samt de fire grundv rdier; *V rdien af det enkelte menneskes v rdighed, v rdien af omsorg, v rdien af sundhed samt v rdien af professionel integritet*⁶².

Case analyse

Vi har nu analyseret og diskuteret os frem til, hvilke kriterier lungecancerpatienten skal besidde for at blive kategoriseret som autonom. Hertil m  vi skelne mellem det autonome valg og det autonome menneske. De Sygeplejeetiske Retningslinjer understreger, at patienten har ret til selvbestemmelse og derved ogs  retten til at frasige sig denne. Men retningslinjerne giver ikke noget svar p , ej heller assistance til, hvorn r patienten er autonom og selvbestemmende. Via den moralske autonomis fordring om respekten for menneskets v rdighed kan vi sikre, at patienten ikke kr nkes eller lignende. Men i tilf ldet med lungecancerpatienten lader det til, at patienten ikke umiddelbart lever op til de krav, som det kantianske autonomi begreb forlanger af fornuftsv snet. Derfor m  vi

⁶¹ Sygeplejeetisk r d 2010. Side 16-17

⁶² Husted, J rgen; *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale]. Side 14-15

belyse patientens forhold under andre betingelser. Som tidligere nævnt lader det til, at patienten fungerer, til en hvis grad, i hverdagen, hvilket betyder, at hun ogs  er i stand til at træffe autonome valg. Dog ikke n r det kommer til afg rende valg for hendes sygdomsforl b og de beslutninger, som n dvendigvis m  træffes. Her lader det til, at hun forn gter de omst ndigheder, hun er underlagt i forl bet og ikke er i stand til at træffe et autonomt valg og s ledes heller ikke i stand til at besidde acceptable grad af selvbestemmelse, n r afg rende valg skal træffes.

Sp rgsm let er nu, hvorledes sygeplejersken skal h ndtere et dilemma som dette i praksis? Hertil m  hun g re brug af de tre etiske teorier, som vi l bende har analyseret og diskuteret specialet igennem. Derudover skal hun inddrage de Sygeplejeetiske Retningslinjer, som giver sygeplejersken et mere praksisorienteret grundlag for sit valg af behandling og pleje vedr rende lungecancerpatienten.

Identifikation

Lad os indledningsvis g  systematisk til v rks med casen og identificere de etiske principper, som er relevante for dilemmaet. Det f rste, vi m  sp rge om, findes i pligtetikkens sf re; er patienten autonom? Beauchamp opstillede, i kantiansk optik, et minimumskriterium for autonomi; *intention, forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse*. I dette skal sygeplejersken vurdere, hvorvidt patienten lever op til minimumskriteriet ved at analysere patientens evne til at besidde autonomi, hvilket vil blive belyst i den *etiske analyse*. Men det er klart, at der allerede p  nuv rende tidspunkt er forhold, som g r det sv rt for sygeplejersken at f  svar p  det konkrete sp rgsm l om, hvorvidt patienten er autonom. Det lader det til, at hun i valget ikke er autonom, men omvendt har vi belyst, at lungecancerpatienten, n r valget ikke omhandler hendes sygdomsforl b, er i stand til at fungere i hverdagspraksis, s  vidt muligt med lungecancer in mente, og derved kan det forekomme problematisk at kategorisere hende som ikke-autonom. I forl ngelse af denne problematik m  sygeplejersken derfor inddrage det konsekvensbetragende perspektiv. Dette perspektiv inddrages med henblik p  at hj lpe patienten til at fremme hendes selvbestemmelsesevne s ledes, at patienten p  sigt kan v re i stand til at træffe et valg,

som begrundes i hendes v rdier og livsanskuelser. Det vil sige, et valg som udspringer fra hendes pr ferencesystem. Er lungecancerpatienten ikke i stand til dette, kan det medf re, at hun foretager et valg, som ikke er autonomt, og derved kr nker hun sin egen v rdighed, hvilket sygeplejersken vil v re medvirkende til, da hun ikke vil leve op til praksisstandarden, som omhandler, at patienten netop bevarer sin v rdighed og integritet.

Vi kan p  nuv rende tidspunkt i proceduren opstille de praksisstandarder, som sygeplejersken skal inddrage i sine overvejelser ang ende pleje og behandling af lungecancerpatienten.

- *Sygeplejersken skal respektere patientens valg, herunder patientens ret til at frav lge selvbestemmelsesretten (§2.3).*
- *Sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin v rdighed og integritet (§2.4).*

Vi har nu identificeret de etiske principper, som er relevant for det etiske dilemma; sygeplejersken skal vurdere, hvorvidt patientens valg er autonomt, hvilket kan st  i konflikt med princippet om at behandle patienten med v rdighed og integritet. Af redskaber kan sygeplejersken benytte sig af pligtetikkenes fordring om at respektere patientens autonomi, eller hun kan fors ge at bidrage til, at patientens selvbestemmelse fremmes. Dette kr ver dog, at patientens  nskede valg tilsides ttes, s ledes at sygeplejersken kan benytte sig af det konsekvensbetragende princip om at fremme selvbestemmelse.

Efterf lgende skal de ber rte parter, det vil s de de parter, som ber res af den valgte behandling og pleje, identificeres. Her er der tale om lungecancerpatienten selv, hendes datter, to sygeplejersker samt det palliative team. Dog vil jeg understrege, at da fokus i analysen er p  forholdet mellem autonomi og sygepleje, vil kun de facetter, som er relevante for dette forhold, inddrages. Af professionsetiske principper inddrages det pligtetiske facet; respekt for autonomi mens vi i det konsekvensbetragende perspektiv inddrager fremme selvbestemmelse.

Sp rsm let er nu, hvilke realistiske muligheder sygeplejerskerne har at v lge imellem; de kan v lge at vurdere lungecancerpatienten som autonom og derved respektere patientens ret til autonomi, hvori de af pligt ikke kan kr enke vedkommende, da dette ikke blot vil v re manglende respekt for hendes autonomi, men ogs  en kr nkelse af hendes v rdighed, da patientens  nske ikke stemmer overens med den professionelle vurdering. Dette betyder, at den positive effekt af paternalistisk indgriben er, at patientens lidelse kan lindres, hvilket er et konsekvensbetragende princip, som er v rdifuldt i denne henseende, da kvinden, p  sigt i forl bet, sandsynligvis kan blive i stand til at tr ffe et rationelt og velbegrundet valg. Den negative konsekvens ved indgriben er, at patienten sandsynligvis vil f le sig st rkt kr nket, da hendes valg og  nsker ikke im dekommes af sygeplejerskerne. Men vurderes kvinden til at v re autonom, bliver den positive konsekvens heraf, at hun er i sin frie ret til at tr ffe sit eget valg og derved selv tage ansvar for konsekvensen af sit valg. Hun kan s ledes ikke terminalerkl res, medmindre at hun har indg et et samtykke, hvori hun v lger at frasige sig selvbestemmelsesretten. Og for at hun kan v re i stand til dette, kr ver det, at hun er autonom.

Vi har nu identificeret de forhold, som g r sig g ldende i den omhandlende beslutningsproces. I det f lgende vil vi analysere og diskutere de etiske forhold, som g r sig g ldende i forhold til denne case og vise, hvorledes de to sygeplejersker skal v re i stand til at begrunde sine faglige valg p  et n dvendigt etisk grundlag.

Etisk analyse

Det etiske dilemma for sygeplejerskerne opst r ved, hvorvidt de skal respektere lungecancerpatientens valg, eller om de skal fors ge at p begynde en proces, hvori patientens autonomi over en periode tilsides ttes for til geng ld p  sigt at v re i stand til at tr ffe et velbegrundet valg. Vi har i analysen og diskussionen vurderet, at patienten ikke er autonom, da hun ikke lever op til Beauchamps kantianske minimumskriterium for autonomi. P  den anden side har vi at g re med en kvinde, som tilsyneladende fungerer; der er ikke noget, som tyder p , at hun ikke kan tage vare p  sig selv, s  l nge denne varetagelse ikke omhandler valg, som har at g re med hendes sygdomsforl b. Ydermere

bekr ftes dette ved datterens tilstedev relse. Datterens tilstedev relse og de informationer vi har om hende udtrykker heller ikke nogen former for umiddelbare tegn p  manglende funktionalitet rent adf rds m essigt, bortset fra ben gtelsen af n dvendigheden af terminalerkl ring af hendes mor.

Sygeplejerskerne st r nu med to valgmuligheder; 1) at kategorisere patienten som autonom, da der ikke er noget som tyder p , at hun, umiddelbart, ikke er i stand til at træffe valg eller 2) v lge at analysere og vurdere patienten p  et rationelt og begrundet grundlag, hvor de belyser de opstillede kriterier, som autonomien begrundes i. F rste valgmulighed kan ikke retf rdigg res; for vurderer sygeplejerskerne ikke patienten, lever de ikke op til det professionsetiske ansvar, at *“...erkende og vedkende sig det etiske faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger⁶³.”* Vurderer sygeplejerskerne, at lungecancerpatienten er autonom og derved i stand til at træffe et rationelt valg, kan man argumentere for at de allerede besidder en p  forh ndstaget beslutning i henhold til, hvad der er bedst for lungecancerpatienten; at respektere hendes valg og  nsker. Men g r de dette, handler de ikke professionelt, fordi de v lger netop ikke at handle, da de endnu ikke har analyseret patientens autonomiforhold. Dette betyder, at sygeplejerskerne ikke har agtelse for pligten i og med, at de i tilf ælde af ikke at have analyseret patienten, ikke lever op til de professionelle standarder, som forventes af dem.

Men sygeplejerskerne skal leve op til kravet om faglig og personlig ansvar for deres etiske valg og handlinger. Det vil sige professionelt at vurdere patienten og stille sp rgsm let; er patienten bevidst om sit valg? Er hendes valg om ikke at ville terminalerkl res et valg, som er truffet p  et rationelt og autonomt grundlag, eller er der tale om en forn gtelse af situationen, hvor valget ikke begrundes, men udelukkende er et udtryk for tilb jeligheder? For at finde svar p  dette, kan vi sp rge, om kvinden lever op til Beauchamps minimumskriterium, og om hun derved er bevidst om sit valg eller ej. De to ansvarshavende sygeplejersker skal vurdere, hvorvidt lungecancerpatienten besidder basal forst else for hendes situation; er hun klar over, at den situation, hun *v lger* at s tte sig selv i, betyder, at hun uds ttes for ulidelige smerter? Smerter som sandsynligvis ville

⁶³ Sygeplejeetisk r d 2010 §1.2

reduceres betydeligt, hvis hun lod sig benytte af muligheden af et palliativ team. Patienten skal v re klar over konsekvensen af dette valg. Dertil lader det, at hun ikke begrunder sit valg p  samme m de, som eksempelvis Freud gjorde det, da han valgte ikke at modtage morfin. I forl ngelse af dette skal hun ogs  besidde en fuld intention, hvori der er kontinuerlig sammenh ng mellem de tanker og  nsker, hun g r sig i henhold til hendes intention. Derudover skal kvinden se sig fri fra kontrollerende omst ndigheder. I vurderingen af patientens valg lader det til, at hun ikke lever op til autonomiens minimumskriterium; vi kan stille sp rgsm lstegn ved, hvorvidt hun har forst else for situationen, hvilket det lader til, hun ikke har, da hun ikke vil h re p , hvad de ansvarlige har at tilbyde og afviser, ubegrundet, deres behandlings- og pleje tilbud. Derved kan vi i pligtetisk henseende konkludere, at kvinden ikke er autonom. Det skal dog noteres, at under den pligtetiske facet - *behandle retf rdigt* - skal man stadig behandle kvinden efter de behov, som hun nu engang har. Sygeplejerskerne kan ikke retf rdigg re en indgriben, hvorved de allerede p  forh nd besidder en masse antagelser om, hvad patienten har behov for. Behandlingen og plejen skal derfor tilpasses den enkelte patient. S ledes kan et indgreb retf rdigg res, men sygeplejerskerne skal stadig respektere patientens v rdighed og integritet. Dog lader det til, at dette ikke kan lade sig g re udelukkende ved brug af pligtetikens principper. Derfor bliver kvindens evne til selvbestemmelse omdrejningspunktet for pleje og behandlingen. Ved at konkludere patienten som ikke-autonom kan sygeplejerskerne oph ve den konflikt, som opstod mellem praksisstandarden  2.3 og  2.4 ang ende henholdsvis at respektere kvindens autonomi og ret til selvbestemmelse samt at sygeplejersken skal arbejde for, at patienten bevarer sin v rdighed og integritet. Derved er sygeplejerskerne i stand til at erkende samt at vedkende sig det etiske ansvar, de besidder i kraft af deres profession samtidig med, at de har form et at anvende en kritiskstillingstagen i henhold til deres profession samt mod og ikke mindst omtanke. Dog er det etiske dilemma ikke l st; sygeplejerskerne har endnu ikke handlet og ageret i situationen, men blot analyseret den. Her bliver Ekstroms koh rensteori aktuell for behandlingen og plejen af patienten. Patienten skal, for at vi kan kategorisere hende som et autonomt individ med dertilh rende personlig autonomi, v re i stand til besidde acceptable og fyldestg rende kontrol over det liv, som hun  nsker at leve. Dertil m  sygeplejerskerne s rge for, via en p dagogisk tilgang, langsomt men

sikkert, overlade patientens selvbestemmelse til den ber rte part. Dette vil sige, at der er tale om en l ngere sigtet proces, hvor sygeplejersken kan v re i stand til, at patienten kan bevare sin v rdighed og integritet samtidig med, at sygeplejersken selv tager det etiske ansvar, hun har i kraft af sin profession ved at bidrage til fremme af patientens selvbestemmelse. Her er det sygeplejerskernes etiske opgave at vurdere patientens evne til at besidde alle fire facetter selvbestemmelsesbegrebet.

Det er dog v rd at bem rke, at pligtetikken samt den konsekvensbetragende etik umiddelbart kan komme til at virke som kolde og kyniske etikker, hvor sygeplejerskerne ikke besidder andet end ligegyldighed overfor lungecancerpatienten. Pligtetikeren respekterer kun patientens autonomi i kraft af, at dette er hendes pligt, og den konsekvensbetragtende etik vurderer kun, hvad der er bedst for patienten ved at vurdere, hvilke konsekvenser som er bedst for patienten - selvf lgelig med vedkommendes pr ferencer og livsanskuelser inkluderet i betragtningen. Derfor m  sygeplejerskerne inddrage et sidste perspektiv i bestr belsen efter at opn  den bedste behandling og pleje. Dette er det ontologiske omsorgs perspektiv. Sygeplejerskerne kan her v lge, ikke kun i kraft af deres profession eller professionalisme, men i kraft af deres egenskab som mennesker, som besidder tilstedev ren, at anse patienten som et medmenneske p  lige fod med dem selv. Mennesket, patient eller ej, kan ikke anskues som en isoleret genstand, men som et medmenneske, som er til stede blandt andre. Den frie sygeplejerske form r at leve op til dette; form r at inddrage de pligter og konsekvenser patienten. G r sygeplejerskerne dette, form r de at undvige fra den ufrie sygeplejerskes stivende ideologi, hvori patienten altid nok er af absolut st rrelse, men derved ogs  altid i et distanceret forhold til sygeplejersken og  vrige professionelle, og det er her, at den h rfine gr nse mellem pleje og omsorg let kan overskrides, og paternalisme bliver det overgreb, som sygeplejersken tyer til. Et overgreb som n dvendigvis altid skal undg s grundet den enkeltes ubetingede v rdighed; et m l-i-sig-selv. Dermed ikke sagt at et paternalistisk indgreb overfor lungecancerpatienten ikke kan retf rdigg res. Dette valg bliver netop retf rdigg rt i og med, at sygeplejerskerne tager det etiske ansvar i deres h nd og vurderer p  et rationelt grundlag, at lungecancerpatienten ikke er autonom. Men de p tvinger ikke kvinden en bedrevidenhed,

men derimod p tager de sig det ansvar, de har for patienten – et ansvar som ikke vil have v ret muligt, hvis de blot undlod at handle og derved antage, at lungecancerpatienten var autonom. Dette ville v re en ubegrundet antagelse, som ikke er nogen patient v rdig. Det professionelle, samt medmenneskelige, ansvar, betyder at sygeplejerskerne skal, for at v re i stand til at medvirke til at lungecancerpatienten modtager tilpasset information i henhold til hendes livssituation, inddrage patientens koh rente pr ferencesystem i behandlingen og plejen.

Denne etiske ansvarlighed, som omsorg og idealer grundl gger, er bindeleddet mellem autonomi, etik og sygepleje. Men den er samtidig ogs  en gr nse, som ikke m  overskrides uden begrundelse; dette skyldes, at professionen kr ver en begrundelse for valget. Sygeplejersken skal altid begrunde sit valg af etiske v rdier. Analysen af lungecancerpatienten understreger vigtigheden af dette; autonomi skal altid respekteres s  l nge, at patienten besidder egenskaben, men g r patienten ikke dette, m  sygeplejersken tilsides tte dette til fordel for princippet om v rdighed og integritet. Sygeplejersken m der ustandseligt etiske konflikter og skal forholde sig til patienternes autonomi mm. Derfor skal sygeplejersken altid afveje sine grunde for derefter at tage i betragtning, hvilken der er mest forsvarlig at v lge. Herefter skal hun s ge r df ring, hvor den etiske analyse pr senteres, og sygeplejersken skal v re  ben for r d og kritik fra sine kollegaer og medmennesker. Afslutningsvis tr ffes det etiske valg; et valg, hvor mennesket altid skal v re et m l, aldrig et middel.

Konklusion

Specialet har belyst, hvilke forhold som g r sig g ldende i henhold til autonomi, etik og sygepleje. Vi har analyseret og diskuteret, hvilke teoretiske baggrunde som danner grundlag for, at sygeplejersken kan l se etiske dilemmaer. Udgangspunktet har v ret autonomi; hvilke teoretiske baggrunde ligger bag dette begreb, og hvilke redskaber skal en sygeplejerske bruge for at vurdere, hvorvidt en patient er autonom. Specialet har taget sit udgangspunkt i et st rkt teoretisk fundament, i form af pligtetikken, og fors gt at g re etikken til en anvendelig praksis. S ledes har vi bev get os fra pligtetik via konsekvensbetragtende etik til et ontologisk omsorgs ideal. Den praktiske anvendelse har vist, at vi via etiske teorier kan opstille en beslutningsmodel, hvorved sygeplejersken har mulighed for at opstille en r kke principper, som g r i tr d med sygeplejefprofessionens praksisstandarder samt m l og v rdier. I casen, omhandlende lungecancerpatienten og hendes autonomi samt selvbestemmelsesforhold, s  vi den praktiske anvendelse af de etiske teorier, og hvordan de kan danne grundlag og begrundelse for sygeplejerskens evne til at foretage et etisk begrundet valg. Dog har vi samtidig set, at sygeplejersken ikke m  g re sin position til endimensionel, rent etisk, da dette kan resultere i, at sygeplejersken ser sig blind p   vrige etiske valgmuligheder.

Jeg har i specialet analyseret og diskuteret grundlaget for autonomi, og jeg har argumenteret for, at patienten altid skal behandles som et m l-i-sig-selv, b de n r patienten besidder autonomi, og n r patienten ikke g r. Besidder patienten egenskaben, skal autonomien altid respekteres. Besidder patienten derimod ikke autonomi, skal vi n dvendigvis stadig behandle patienten som et m l-i-sig-selv. Dog inkluderer dette, at sygeplejersken skal hj lpe patienten med at besidde magt over egen tilv relse ved at fremme patientens evne til selvbestemmelse og de facetter, som h rer herunder.

Det teoretiske grundlag for specialet har taget udgangspunkt i Immanuel Kants autonomibegreb. Dette begreb er et rent moralsk begreb, hvori fornuftsv esenet har et objektivt a priori grundlag, som giver etikken et absolut udgangspunkt i og med, at det beskytter det enkelte menneske mod overgreb i kraft af, at fornuftsv snet altid er m l-i-sig-selv. Dette sikrer, at sygeplejersken altid har et sikkert fundament, som er h vet over

antagelserne. Netop antagelser kan ikke bruges som grundlag for etik i sygeplejen, fordi de ikke besidder et sikkert epistemisk grundlag, og vi kan ved anvendelse af antagelse frygte, at etikken funderes i doxa. Dette betyder derfor, at vi i kantiansk optik m  skelne mellem de moralske a priori principper samt formalier, som findes i moralloven og de a posterioriske, som findes i antagelsens tilb jeligheder. En handling, som grundles i sidst n vnte, kan ikke besidde moralsk v rdi og kan derfor ikke betragtes som v rdifuld i kantiansk perspektiv. Herved bliver fornuften en afg rende faktor i kantiansk optik, fordi den sikrer, at sygeplejersken handler efter en gyldig almen lov. Dette er grundfundamentet for al sygepleje, fordi det sikrer, at hvert enkelt unikt fornuftsv sen altid og ubetinget sikres sin autonomi.

Analysen har dog vist, at Kants moralske autonomi umiddelbart er sv rt tilg ngelig i praksis. Derfor har vi ved brug af Beauchamp opstillet et minimumskriterium for autonomi, som inkluderer *intention*, *forst else* og *fri af kontrollerende indflydelse*. Dette g r, at sygeplejersken besidder et praksisanvendeligt redskab til at vurdere, hvorvidt patienten er i stand til at foretage autonome valg. S ledes har analysen argumenteret for, at der ikke kun opstilles krav til sygeplejersken og hendes profession, men ogs  at patienten er i stand til at opfylde kriterier, s ledes at vi kan tale om en autonomi, som n dvendigvis skal respekteres. I forl ngelse af det praksisanvendelige autonomibegreb opstillede vi casen med lungecancerpatienten, hvor vi diskuterede, hvorvidt den ber rte kvinde var autonom eller ej. I sine overvejelser af dette skal sygeplejersken ikke kun forholde sig til sp rgsm let om autonomi, men ogs  til principperne om at behandle patienten retf rdigt og undg  skade. Hertil skal sygeplejersken medvirke, til at patienten modtager og forst r den information, som formidles i henhold til De Sygeplejeetiske Retningslinjer  2.2 samt den information, som patienten modtager, tilpasses patientens livssituation. Beauchamps minimumskriterium kan begrunde, hvorfor patienten ikke er autonom, og at vi derfor har behov for en svag paternalisme; ikke en p f relse af et gode, men en afv rgelse af et onde. Men vi m  dog p pege, at hvorledes vi skal v re i stand til at afv rge et onde, kan pligtetikken ikke svare p . Den henholder sig udelukkende til pligten og deraf ogs  en kritik af etikken. Den beskytter og sikrer patientens rettigheder, men den er ikke i stand til at tilbyde en facet, hvor vi kan hj lpe patienten, da dette vil v re et

konsekvensbetragtende perspektiv. Men i henhold til pligtetikken kan der ved denne facet ikke v re tale om etisk handlen af v rdifuld moralsk karakter, fordi vi bev ger os v k fra fornuften og pligten og i stedet fokuserer p  konsekvensen. Men i og med moralen ikke kan finde v rdi i konsekvensen af handlingen, kan pligtetikken ikke assistere patienten i henhold til fremme af selvbestemmelse.

S ledes har vi i analysen diskuteret behovet for en autonomi definition, som ikke begrundes p  et kategorisk grundlag, hvor vi kun kan vurdere, om det enkelte valg er autonomt og ikke den specifikke person. Det er n dvendigt for, at sygeplejersken kan medvirke til, at patienten er i stand til at ud ve selvbestemmelse og dertilh rende facetter. Men som vi har diskuteret, kan det forekomme problematisk for sygeplejersken at skulle respektere patientens valg og ret til selvbestemmelse, hvis hun ikke har noget grundlag for at vurdere patientens evne til at besidde selvbestemmelse samt at v re i stand til at bevare patientens v rdighed og integritet uden noget kendskab til vedkommendes livsanskuelser. For at l se dilemmaet mellem disse konflikter har vi anvendt Laura Waddell Ekstroms koh rente pr ference teori omhandlende det integrerede selv. At v re i stand til at vurdere en patients evne til selvbestemmelse betyder, at vi m  inddrage et refleksivt lag, som ikke er til stede hos hverken Kant eller Beauchamp. Dette er n dvendigt for, at sygeplejersken kan f  forst else af patientens definition af *det gode*, s ledes at en eventuel behandling og pleje kan tilrettel ggelse efter patientens subjektive vurdering. Patientens karaktersystem, hvori dets integrerede selv og valg af pr ference findes, m  sygeplejersken have med i sin vurdering, n r patienten skal bed mmes som autonom eller ej. I dette bliver det ogs  muligt for sygeplejersken at pleje og behandle patienten med v rdighed, fordi vedkommende livsanskuelser og pr ferencer medindtages i overvejelserne, n r behandlings- og plejeprocessen igangs ttes. Dette betyder selvf lgelig ogs , at Ekstroms autonomibegreb bliver et mere komplekst begreb end det kantianske, da det omhandler et langt bredere perspektiv end Beauchamps minimumskriterium.

Ved pleje og behandling af lungecancerpatienten giver Ekstroms teori sygeplejersken mulighed for at bevare patientens v rdighed og integritet, men den kan ogs  svare p , hvorvidt patienten er i stand til at besidde selvbestemmelse. Kan sygeplejersken v re

med til at fremme patientens selvbestemmelse, s  kan hun tilpasse de informationer, som patienten har krav p  i henhold til De Sygeplejeetiske Retningslinjer, hvorved hun *medvirker til, at patienten modtager og forst r den information, der er n dvendig for at træffe valg. Information, der gives, skal v re tilpasset den enkelte patients  nsker og behov samt livssituation* jf. §2.2. Dette betyder, at patienten skal v re i stand til at besidde de facetter, som selvbestemmelsesbegrebet indbefatter; autonomi, selvansvarlighed, selvstyre og selvudvikling. Besidder patienten disse facetter, skal sygeplejersken n dvendigvis altid respektere patientens pr ferencer og dertilh rende valg og  nsker. Besidder patienten til gengæld ikke den  nskede grad af selvbestemmelse, kan vi argumentere for anvendelse af Voksen-ung-modellen, som giver sygeplejersken mulighed for en konkret medvirken til patientens udvikling i henhold til selvbestemmelse og derved sikre medvirken til, at patienten modtager og forst r den information, som er n dvendig for patienten for at træffe valg.

Tilfældet med lungecancerpatienten viser, at patienten ikke besidder tilstr kkelig grad af selvbestemmelse i henhold til patientens sygdomsforl b og derved m  Voksen-ung-modellen tages i brug. Men vi kan ogs  forestille os situationer, hvor en autonom patient som besidder fuld evne til selvbestemmelse, ikke  nsker den foresl ede behandling. Dette s  vi ved eksemplet med Freud, i afsnittet *Konflikten mellem den personlige autonomis begrundede valg og paternalisme*, hvor Freud ikke  nskede at modtage morfin, da han  nskede et klart hoved. Ved s danne begrundede tilfælde kan sygeplejersken ikke retf rdigg re et u nsket indgreb, da hvert enkelt autonomt menneske har ret til at leve det liv, som dette menneske  nsker, s  l nge at det ikke skader andre. Og modsat lungecancerpatienten giver Freud begrundelse for, hvorfor han ikke  nsker behandling, og derved er der lighedstegn mellem hans integrerede selv og det  nskede valg; Freud har forst et de informationer, sygeplejersken har givet, men  nsker samtidig at bevare sin v rdighed og integritet; dette vurderer han til kun at kan lade sig g re ved ikke at modtage morfin. S danne  nsker og valg m  ikke kr enkes, hvis sygeplejersken  nsker at leve op til De Sygeplejeetiske Retningslinjer fordring om bevarelse af v rdighed og integritet.

Men det er klart, at i forholdet mellem etik i sygeplejen og autonomi har begrebet omsorg en afg rende rolle, da den tilbyder en n rv r, som hverken den moralske eller personlige autonomi er i stand til. Ved brug af L gstrup har vi konkluderet, at lungecancerpatienten er mere end blot en patient; hun er ogs  et menneske p  lige fod med l ger og sygeplejersker. Herved f r de professionelle et medmenneskeligt ansvar, som ikke er til stede i hverken pligtetikken eller den konsekvensbetragtende etik. Med dette ansvar har vi vurderet, at sygeplejersken m  tage ansvar for patienten og ikke fra patienten, som tilf ldet ganske givet let kan ske ved de  vrige teorier. Derved skal sygeplejersken, i det etiske dilemma, bl.a. ogs  inddrage lungecancerpatientens datter i forl bet og  vrige ber rte parter, s ledes at man ogs  kan f  begges v rdier og holdninger i spil, n r hun g r sine overvejelser. Filosofen Kari Martinsen, som skriver Knud Ejler L gstrups etik ind i sygeplejen, vurderer, at via fantasien kan sygeplejersken s tte sig i og forst  patientens sted og derved have indblik i et mere eksistentielt perspektiv p  det etiske dilemma i henhold til lungecancerpatienten. S ledes m  sygeplejersken bruge en sk nm essighedstagen for at vurdere dette. Men den ontologiske omsorgsetik m  vi n dvendigvis kritisere, hvilket vi gjorde i afsnittet *Kritik af det ontologiske omsorgsideal*, fordi vi kan risikere at miste det faste grundlag som pligtetikken, samt den konsekvensbetragtende etik, gav os, og derved kan behandlingen og plejen af patienten risikere at ende i en misologi, hvorved vi forkert antager, hvad der er bedst for den enkelte patient.

I afsnittet *De Sygeplejeetiske Retningslinjer – Den Professionsetiske Beslutningsmodel anvendt i praksis* har vi bev get os ind p  en mere praksisorienteret anskuelse af forholdet mellem autonomi, etik og sygepleje. Her har vi indskrevet de principper, som vi har udarbejdet ind i forl bet omhandlende sygeplejerskernes praksisstandarder (De Sygeplejeetiske Retningslinjer) samt m l og v rdier. Derved har vi v ret i stand til, via Professionsetiske Beslutningsmodel, at ops tte punkter, som skal med-indt nkes, n r et etisk dilemma skal l ses. Heriblandt at respektere patientens autonomi og fremme interesse mm. Sygeplejersken skulle derved gerne v re i stand til at begrunde sine valg i henhold til et etisk dilemma ved brug af de tre opstillede teorier samt ud ve etisk refleksion, hvilket beslutningsmodellen er et redskab til. Derved kan sygeplejersken leve

op til sine fire ansvars omr der samt s tte hende i forhold til; *profession, patienten, medarbejder* og *samfundet* samt de fire grundv rdier; *V rdien af det enkelte menneskes v rdighed, v rdien af omsorg, v rdien af sundhed* samt *v rdien af professionel integritet*.

Med disse redskaber har vi bev get os fra filosofisk teori til praksisanvendelighed i sygeplejen. Derved skulle sygeplejersken gerne v re i stand til at l se etiske dilemmaer. Anvendelsen af de brugbare redskaber kom til orde i det afsluttende afsnit *Case analyse*, hvor de to sygeplejersker skulle forholde sig til lungecancerpatientens evne til autonomi, og hvorledes konflikten mellem de n vnte praksisstandards l ses; via analyse blev lungecancerpatienten vurderet til ikke at besidde autonomi eller tilstr kkelig grad af selvbestemmelse.

Indledningsvis identificerede vi casen; hvilke etiske principper har v ret relevant for dilemmaet? Hvilke handlemuligheder var mulige i henhold til pligtetikken, den konsekvensbetragende etik og omsorgsetikken. Derefter p begyndte vi den etiske analyse, hvor vi konkluderede, at lungecancerpatienten ikke var autonom, og at hun ikke var i stand til at besidde magt over egen tilv relse vedr rende hendes sygdomsforl b; hun besad s ledes ikke en tilfredsstillende grad af selvbestemmelse.

Afslutningsvis vil jeg n vne, at sygeplejersken altid skal anskue et etisk dilemma fra alle tre etiske teorier; man m  aldrig fors ge at l se s danne dilemmaer med endimensionel etisk tilgang, da s danne ensrettet livsforst else er f rsteinstans for sk rpelse af det enkelte specifikke menneske. Men n r det s  er sagt, s  vil jeg mene, at mennesket, ubetinget, altid er det ubestridte m l-i-sig-selv, hvilket pligtetikken ogs  fordrer. Dette betyder dog ikke, at pligtetikken er hierarkisk mere v rd end henholdsvis den konsekvensbetragende etik og den ontologiske omsorgs etik, men det betyder, at i og med at mennesket altid er m l-i-sig-selv, skal autonomi altid respekteres, fordi man ikke retf rdigvis kan kr nke autonomien. Dette speciale har fors gt at vise, hvor n dvendigt autonomi er i henhold til behandling og pleje af patienten; den autonome patient er i stand til at besidde moralsk autonomi samt personlig autonomi. Det vil sige, at vedkommende kan give udtryk for egne v rdier og pr ferencer, og derved kan

patientens v rdighed og integritet altid bevarer, s  l nge autonomien ikke kr enkes. Mere besv rligt bliver det, n r en patient ikke besidder autonomi eller besidder en manglende evne til selvbestemmelse. Netop selvbestemmelse er et n glebegreb, da sygeplejersken skal medvirke til at fremme selvbestemmelse hos patienten s  vidt muligt. Netop her ser vi, hvorfor pligtetikken ikke kan st  alene som eneste anvendelige etik i sygeplejen; den kan ikke sige noget om menneskets pr ferencer og personlige autonomi, men forholder sig kun til objektiv moralske autonomi. Dette perspektiv er nemlig ogs  en n dvendighed, da selvbestemmelsesretten sikrer patientens ret til at sige fra, hvis patienten ikke  nsker den foresl ede behandling. Men mere vigtigt sikre den konsekvensbetragende etik, at patienten, hvis vedkommende besidder selvbestemmelse, kan indg  informeret samtykke. Dette samtykke er fundamentalt i henhold til patienten og institutionen, da patientens samtykke skal gives p  baggrund af tilstr kkelig og fyldestg rende information, hvorved sygeplejersken har pligt til, at patienten forst r disse. Deraf n dvendigheden af selvbestemmelse. Det er klart, at der forekommer eksempler, hvor patienten er inhabil i s  kraftigt en grad, at selvbestemmelsesbegrebet ikke kan komme til realisering. Men ved patienter, hvor tilf eldet er, at de ikke kan varetage egne interesser, men p  sigt eventuelt ville v re i stand til dette, bliver det at bidrage til, at patienten kan fremme og besidde magt over egen tilv relse, n dvendigt s ledes at man kan varetage patientens interesser p  samh rig vis og p  sigt sikre, at vedkommende selv ville v re i stand til at besidde evnen.

Mennesket er altid et m l-i-sig-selv, og derved skal autonomien altid respekteres, s  l nge at der er en autonomi at respektere, men er autonomien ikke tilstede, skal mennesket stadig behandles ligev rdigt og med v rdighed; som m l, aldrig som middel.

Engelsk resumé / English resume

This thesis raises an issue on the relation between autonomy, ethics and nursing. It is a philosophical analysis and discussion which emphasizes the need for categorizing the individual as an unique autonomous being whose right and autonomy must not be violated.

According to Immanuel Kant's deontological moral theory, only rational beings are able to possess the capacity of autonomy. Kant argues that the fundamental principle of our moral duties is a categorical imperative. In nursing ethics this is the key fundament of ethics because it exercises the nurses will in a specific way in which the nurse only can act according to duty. This prevents that the treatment of a patient is not being founded on the random act or emotion. However, the Kantian deontology can only define the autonomous choice and not the autonomous person. Deontology might prevent violation of the patient's autonomy, but it does not offer any indication on how to treat a patient who does not possess the capacity of autonomy. Therefore nursing ethics needs yet another philosophical theory in the search for such for a wider treatment perspective. In addition the thesis has argued that the Kantian concept of autonomy might be too narrow. This is despite the fact that Tom L. Beauchamp tried to set up a practical use of Kant's concept of autonomy. This practical use required the patient to be able to possess *understanding, intention* and *free will*. By the use of Laura Waddell Ekstrom's complex autonomy theory we have been able to add an extra layer in the discussion on what it takes to be an autonomous person. Ekstrom offers a conception of a coherentist theory of autonomy in which we have to understand the beings self and its values before the nurse can start the treatment of the patient. This means that the nurse now has a treatment-model, in which the nurse is able to help the patient to possess self governance or at least help the patient in the direction of this specific aim. In the case of the woman being diagnosed with a severe lung cancer, the thesis emphasized the need of this philosophical tool.

Deontology and the consequence calculation ethics, represented by Ekstrom, is not enough. We also need a theory which represents nursing ethics more specifically. In this

we have argued that sometime the nurses need a merely phenomenological and humane view on the patients. In addition to this Knud Ejler L gstrup has been used in a way to include the human understanding of the specific patient.

By using these three ethical theories the nurse now has a tool to solve the ethical dilemmas she confronts everyday whilst at work. However, the nurse also has to include the nursing ethics' practical standard formula which can be found in the nursing-ethical guidelines. By using these tools the nurse should be able to categorize a patient as being autonomous or non- autonomous. But no matter the outcome – the nurse must per definition treat the patient with integrity and respect.

Jesper Jungl w Nielsen

(20051093)

Litteraturliste

Beauchamp, Tom L: *Who Deserves Autonomy, and Whose Autonomy Deserves Respect?* Fra: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Redigeret af Taylor, James Stacey. Cambridge University Press, 2005.

Birkler, Jacob: *Filosofi & sygepleje – Etik og menneskesyn i faglig praksis*. Munksgaard Danmark, K benhavn, 2003.

Childress, James F. og Tom L. Beauchamp: *Principles of Biomedical Ethics*. 3. Udgave. Oxford University Press, 1989.

Ekstrom, Laura Waddell: *Autonomy and Personal Integration. Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy*. Redigeret af Taylor, James Stacey. Cambridge University Press, 2005.

Husted, J rgen: *Etik og v rdier i socialt arbejde*. 1. Udgave. Hans Reitzels Forlag, 2009.

Husted, J rgen: *V rdier og etik i Sygeplejen* [Upubliceret materiale].

Kant, Immanuel: *Grundl ggelse af S dernes Metafysik*. P  dansk ved og med indledning af Tom B geskov. Hans Reitzels Forlag, K benhavn, 1999.

L gstrup, Knud Ejler: *Den Ethiske Fordring*. 9. Oplag. Gyldendal, K benhavn, 1975.

Martinsen, Kari: *L gstrup & sygeplejen. P  dansk ved Joachim Wrang*. Forlaget Klim, 2012.

Mill, John Stuart: *Om Friheden*. Fra: Mill om friheden; *Overs ttelse og Guide* af J rgen Husted. Philosophia, Aarhus, 2008.

Mill, John Stuart: *Utilitarisme. Overs ttelse, indledning og efterskrift* ved Helge N rgaard Madsen. Det Lille Forlag, 2008.

Platon: *Lovene*. Udgivet ved H eg, Carsten og R eder, Hans. C.A. Reitzels Forlag, 1940.

Politikkens filosofi leksikon. Redigeret af Poul L bcke. Forfattere: Anne Gr n, J rgen Husted, Poul L bcke, Stig Alstrup Rasmussen, Peter Sand e og Niels Christian Stefansen. 1. Udgave, 18. oplag. Politikens Forlagshus, K benhavn, 2006.

Sygeplejeetisk R d 2010. Dansk Sygeplejer d.

Taylor, James Stacey: *Personal Autonomy – New Essays on Personal Autonomy and its Role in Contemporary Moral Philosophy, Introduction*. Cambridge University Press, 2005.